



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN KINERJA
KOMITE PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN INFEKSI**

**BULAN MARET
TAHUN 2025**

Jl. Raya Surabaya - Malang No. KM 54, Sukorejo - Pasuruan

Telp. 0343 - 6745000

Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

**LAPORAN KINERJA KOMITE PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI)
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO
TAHUN 2025**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Umum/Latar belakang

Rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu rumah sakit dituntut untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Disisi lain, rumah sakit menjadi mata rantai transmisi penyakit. Penyakit infeksi terkait pelayanan kesehatan atau *Healthcare Associated Infections* (HAIs) merupakan salah satu masalah kesehatan di berbagai nega di dunia, termasuk Indonesia. Dalam forum *Asian Pasific Economic Comitte* (APEC) atau *Global Health Security Agenda* (GHSA) penyakit infeksi terkait pelayanan kesehatan telah menjadi agenda yang dibahas. Hal ini menunjukkan bahwa HAIs yang ditimbulkan berdampak secara langsung sebagai beban ekonomi negara.

Secara prinsip, kejadian HAIs sebenarnya dapat dicegah bila fasilitas pelayanan kesehatan secara konsisten melaksanakan program PPI. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi merupakan upaya untuk memastikan perlindungan kepada setiap orang terhadap kemungkinan tertular infeksi dari sumber masyarakat umum dan disaat menerima pelayanan kesehatan pada berbagai fasilitas kesehatan.

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, khususnya di bidang pelayanan kesehatan, perawatan pasien tidak hanya dilayani di rumah sakit saja tetapi juga di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, bahkan di rumah (*home care*).

1.2. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi dan Fasilitas Kesehatan Lainnya.
2. Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Nomor 449.5/RSPHS/I-PER/DIR/III/2022 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

1.3. Maksud dan Tujuan

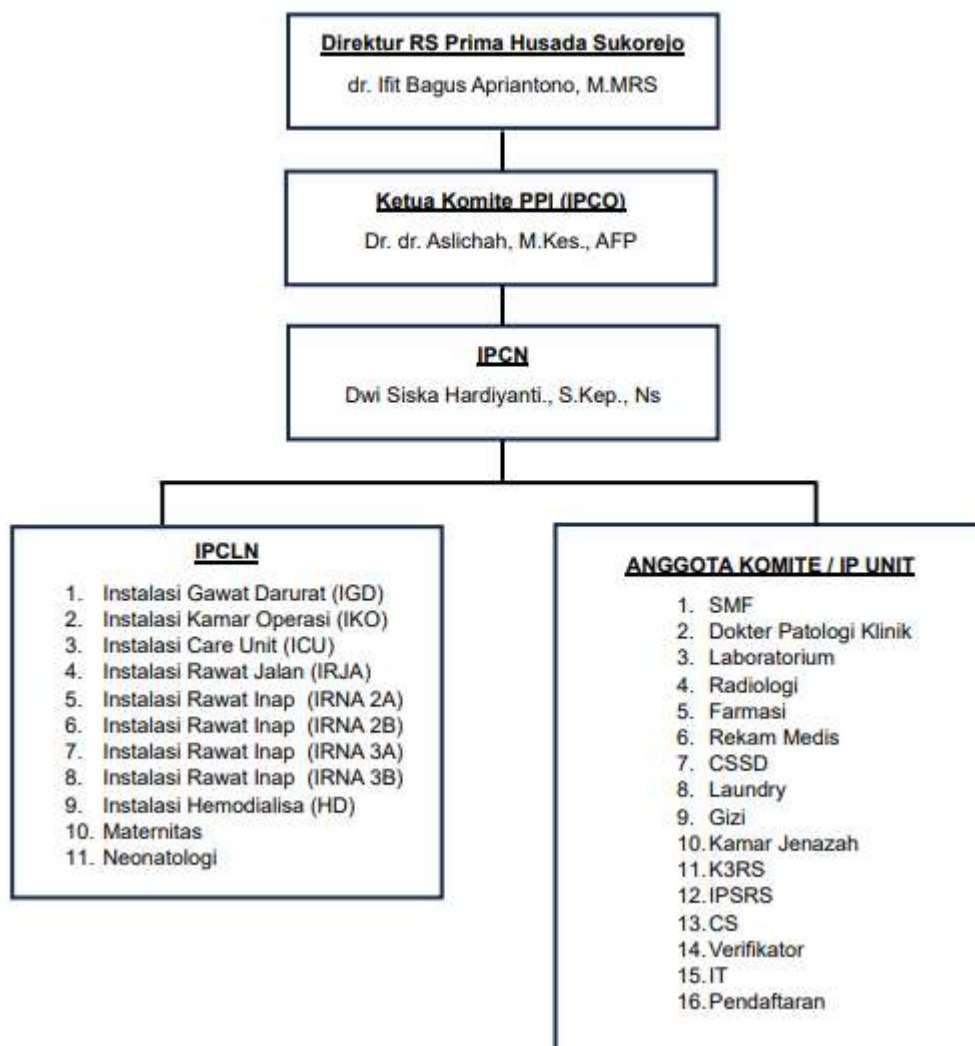
Sebagai panduan untuk pencapaian visi dan misi RS Prima Husada Sukorejo dalam mencapai tujuan organisasi yaitu memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan professional melalui penerapan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi, sehingga setiap individu dapat bekerja secara sistematis dan terstruktur.

BAB II GAMBARAN UMUM

- 2.1 Visi
Menjadikan rumah sakit berkualitas prima pilihan seluruh lapisan Masyarakat
- 2.2 Misi
1. Memberikan pelayanan Kesehatan dengan aman, cepat, tepat, dan akurat.
 2. Mengutamakan kepuasan dan keselamatan pasien
 3. Meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan
- 2.3 Motto
“Clean Hands, Save Lives”
- 2.4 7 Nilai Budi Utama
1. Jujur
 2. Tanggung jawab
 3. Dipercaya
 4. Visioner
 5. Kerjasama
 6. Adil
 7. Peduli
- 2.5 SOTK

Gambar 1. SOTK Komite PPI 2025

SOTK KOMITE PPI



BAB III.

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DAN HASIL YANG DICAPAI

- 3.1 SDM :
- 3.1.1 Ketenagaan (distribusi tenaga, kualifikasi dan kebutuhan)

Jabatan	Analisis Beban Kerja	Jumlah SDM												Kebutuhan	Ket.
		Bulan Ke-													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
IPCO	1	1	1	1										1	Peremenkes No 27 tahun 2017 1 IPCN = 100 TT
IPCD	1	-	-	-										1	
IPCN	1	1	1	1										1-2	

- 3.1.2 Orientasi
- Tabel 3.1.2. Pelaksanaan Orientasi PPI bagi Karyawan baru RSPH Pasuruan Tahun 2025

No	Bulan	Jumlah Peserta	Pelaksanaan	Hasil Evaluasi orientasi
1.	Januari	Tidak ada orientasi staff baru pada bulan Januari 2025		
2.	Februari	Tidak ada orientasi staff baru pada bulan Februari 2025		
3.	Maret	Tidak ada orientasi staff baru pada bulan Maret 2025		
4.	April			
Total				

Tabel 3.1.4.1 Evaluasi Kinerja Staf Berdasarkan Pelaporan Surveilans

[illegible]

Tabel 3.1.4.2 Evaluasi Kinerja Staf Berdasarkan Pelaporan Bulanan

[illegible]

Tabel 3.1.4.3 Evaluasi Kinerja Staf Berdasarkan Pelaporan Edukasi

[illegible]

[illegible]

Tabel 3.1.4.6 Evaluasi Kinerja Staf Berdasarkan Pelaporan Audit APD

[illegible]

[illegible]



Tabel 3.1.4.8 Hasil Penilaian PIC PPI Unit Bulan Maret 2025

UNIT	SURVEILANS	LAPBUL	EDUKASI	AUDIT HH	AUDIT APD	AUDIT PROGRAM	NILAI
ICU	100	80	100	93	93	0	78
IGD	93	80	100	100	87	0	77
IKO	37	63	0	50	40	0	32
IRJA	73	67	50	67	27	0	47
IRNA 2A	100	80	67	100	80	0	71
IRNA 2B	87	80	83	93	80	0	71
IRNA 3A	93	80	100	93	87	0	76
IRNA 3B	87	75	83	73	73	0	65
MATER	93	80	100	93	93	0	77
NEONATOLOGI	100	80	100	93	93	0	78
GIZI & DAPUR	0	80	0	93	80	0	42
FARMASI	0	67	0	53	53	0	29
LAB	0	80	0	87	87	0	42
RM & PDF	0	63	33	0	0	0	16
RADIOLOGI	0	63	17	47	47	0	29
CSSD & LAUNDRY	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 3.1.4.9 Analisa dan Tindak Lanjut Penilaian Kinerja PIC PPI Unit 2025

Analisa	Berdasarkan hasil capaian dan evaluasi penilaian kinerja staf IPCLN dan PIC PPI bulan Maret tahun 2025 dengan penugasan sebagai berikut, - Pelaporan surveilans - Pelaporan dan penginputan laporan <i>by link</i> - Pemberian edukasi kelompok dan individu dengan sasaran pasien, pengunjung serta staf unit - Pelaporan audit HH - Pelaporan audit APD - Pelaporan audit program Dapat diketahui bahwa pelaporan belum berjalan secara maksimal, dan masih ditemukan beberapa unit yang tidak patuh dalam melakukan pelaporan secara <i>real time</i>. Adapaun unit dengan skoring tertinggi dan menjadi PIC teladan pada bulan Maret tahun 2025 yakni ICU dan Neonatologi dengan skor 78.
Rencana Tindak Lanjut	- Berikan penilaian kinerja setiap bulan pada saat melakukan rapat koordinasi komite PPI - Lakukan perbaikan dengan IPCO setiap kali melakukan agenda rapat dalam pembahasan temuan-temuan serta kendala pada masing-masing unit - Berikan motivasi kepada PIC PPI unit yang belum maksimal dalam melakukan penugasan serta evaluasi secara bersama dengan IPCO - Lakukan koordinasi dengan Kabid serta SDM terkait kepatuhan unit dan staff dalam proses menjadi seorang PIC PPI di unit

3.2 Hasil Pengembangan Pelayanan

Tabel 3.2.1 Pengembangan Pelayanan

No	Kegiatan	Bulan	Hasil	Analisa	Rencana Tindak Lanjut
1	Pelatihan	Januari	Tidak ada staff yang melakukan pelatihan internal atau eksternal di bulan Januari 2025		
2	Pelatihan	Februari	Tidak ada staff yang melakukan pelatihan internal atau eksternal di bulan Februari 2025		
3	Pelatihan	Maret (22/03/2025)	1. IDO (Infeksi daerah operasi) bisa di sebabkan oleh faktor endogen (usia, penyakit penyerta, jenis kelamin, pola hidup) dan eksogen (tipe dan lama operasi, keahlian tim bedah, pemilahan operasi, pemasangan impaln, sterilisasi instrumen bedah, kualitas ruang op, kualitas fasilitas/peralatan yang ada di ruang operasi) 2. 4 klasifikasi luka IDO 1) Luka bersih 1-2% 2) Bersih terkontaminasi 6-9% 3) Luka terkontaminasi 13-20% 4) Luka kotor 40% 3. Pemberian profilaksis di lakukan 1 jam sebelum insisi dan sesegera mungkin sebelum dilakukan pembedahan 4. Pemberian profilaksis harus berbeda dengan terapi AB yang digunakan pasien selama proses rawat inap 5. Dikatakan IDO ketika 1) post op hari ke 30-90 yang disertai dengan demam, kemerahan, bengkak, keluar pus	1. Belum adanya SPO pembersihan ruang IKO yang ter-update 2. Tidak patuh dan rutinnya jadwal bongkaran di ruang IKO 3. Tidak patuhnya staff IKO dalam melakukan tatalaksana ruang operasi sesuai dengan prosedur 4. Penerapan bundle IDO di RS belum berjalan sesuai dengan standart 5. Jadwal pemberian profilaksis (antibiotik) di setiap unit masih belum berjalan maksimal 60 menit sebelum jam insisi 6. Masih ditemukan alat di ruang IKO tidak terpusat di CSSD dalam proses pembersihan	1. Pembuatan SPO pembersihan ruang IKO 2. Pembuatan jadwal bongkaran IKO 3. Sosialisasi dan re-edukasi kepatuhan petugas dalam melaksanakan tatalaksana ruang operasi 4. Penerapan bundle IDO oleh unit IKO dan all unit rawat inap serta rawat jalan 5. Edukasi pemberian profilaksis (antibiotik) harus 60 menit sebelum insisi 6. CSSD melakukan pendaataan dan edukasi ulang terkait instrumen yang ada di IKO wajib dilakukan pembersihan dan sterilisasi di CSSD



			2) golden period terjadi pada hari ke 0-30 hari 6. Dampak IDO 1) memperpanjang masa rawat, sering re-admisi, kebutuhan ICU 2) mortalitas meningkat 3) disabilitas permanen 4) prosedur bedah tambahan 5) kontribusi pada peningkatan resistensi antibiotik 7. Teknik penerapan IDO 1) Pre operatif : mandi dengan clorhexidin sehari sebelum op dan hari H ketika proses pembedahan, pencukuran menggunakan cleaper (dilakukan di RS supaya terkontrol oleh petugas tekniknya), pemberian antibiotik kurang dari 120 menit 2) Intra operatif : pemberian O2, pemantauan suhu tubuh, pemantauan gula darah 8. Bongkaran/pembersihan IKO 1) pembersihan harian (dilakukan selama prosedur op telah selesai semua) 2) bongkaran 1 minggu sekali (dilakukan secara rutin dan terjadwal) 3) bongkaran 1 bulan sekali 4) pembersihan pasca renovasi 9. Pembersihan lingkungan		
--	--	--	--	--	--



			1) terdapat SPO tersendiri dalam pembersihan ruang khusus (iko) 2) melakukan pemeriksaan lingkungan secara rutin (6 bulan sekali) 10. kualitas ruang operasi 1) pintu otomatis 2) tempat cuci tangan menggunakan sensor 11. alur instalasi ruang bedah 1) zona luar : koridor masuk, area transfer, nurse station, area dokumentasi, preoperasi, area ganti baju 2) zona bersih : koridor bersih, ruang simpan alat steril, ruang anastesi dan RR, area istirahat 3) zona retriksi : scrub sinks, ruang operasi 12. persiapan alat/instrumen 1) alat "non kritis" 2) alat "semi kritis" 3) alat "kritis" 13. prinsip rawat luka pasien post op 1) assesmen komprehensif luka dan pasien 2) pengendalian infeksi 3) pemilihan dressing yang tepat 4) manajemen nyeri 5) pendidikan pasien dan keluarga 14. tata kelola kamar operasi		
--	--	--	--	--	--



			1) penjadwalan operasi : mengatur (mengatur kamar operasi, operator dna tim operasi, durasi op) 2) persiapan pasien 3) koordinasi tim medis 4) pengurangan waktu tunggu 5) alur pasien yang efisien 15. manajemen linen 1) penanganan linen di kamar op harus sesuai 2) pemisahan linen kotor terkontaminasi darah atau cairan tubuh dengan linen kotor tidak terkontaminasi 3) tidak menempatkan linen di lantai 4) semua linen infeksius dimasukkan ke dalamkantong dengan kode infeksius 5) linen yang terkontaminas cairan tubuh dibersihkan sebelum proses selanjutnya 16. manajemen limbah 1) pisahkan limbah sesuai dengan jenisnya 2) tempatkan limbah sesuai dengan jenisnya 17. sterilisasi dan perawatan peralatan medis 1) sterilisasi alat bedah 2) desinfeksi permukaan 3) penyimpanan yang tepat 4) pemeliharaan yang rutin		
--	--	--	---	--	--



			18. semua peralatan/intrumen bedah wajib di lakukan sterilisasi di CSSD 19. ruang/gedung kamar operasi : boleh sampai dengan lt. 4 dengan memperhatikan struktur dan arah cahaya dari banguna		
--	--	--	---	--	--

[illegible]

[illegible]

b. Kewaspadaan Isolasi

[illegible]

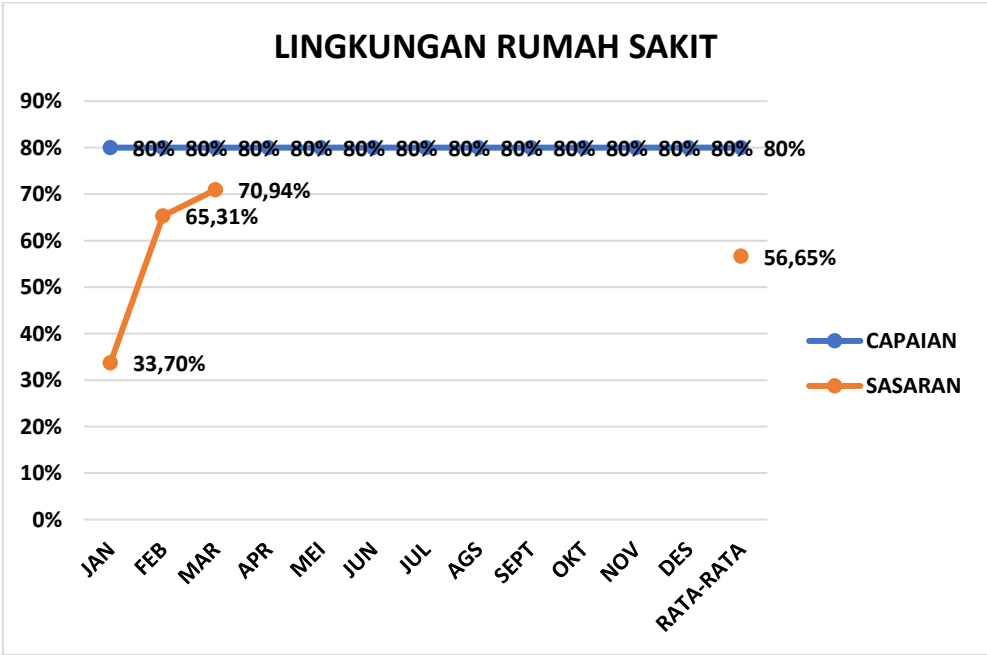
[illegible]

[illegible]

BAB IV.

PEMBAHASAN KINERJA PRODUKTIFITAS KOMITE PPI

- 4.1 Kinerja Produktifitas Komite PPI
- 4.1.1 Monitoring Kewaspadaan Isolasi
- a. Kewaspadaan Standart
- a) Lingkungan Rumah Sakit
- Gambar 4.1.1.1 Lingkungan Rumah Sakit



Interpretasi : Pada gambar 4.1.1.1 diketahui bahwa rerata lingkungan rumah sakit di bulan Maret 2025 sebesar 70,94% dan belum mencapai standart 80%.

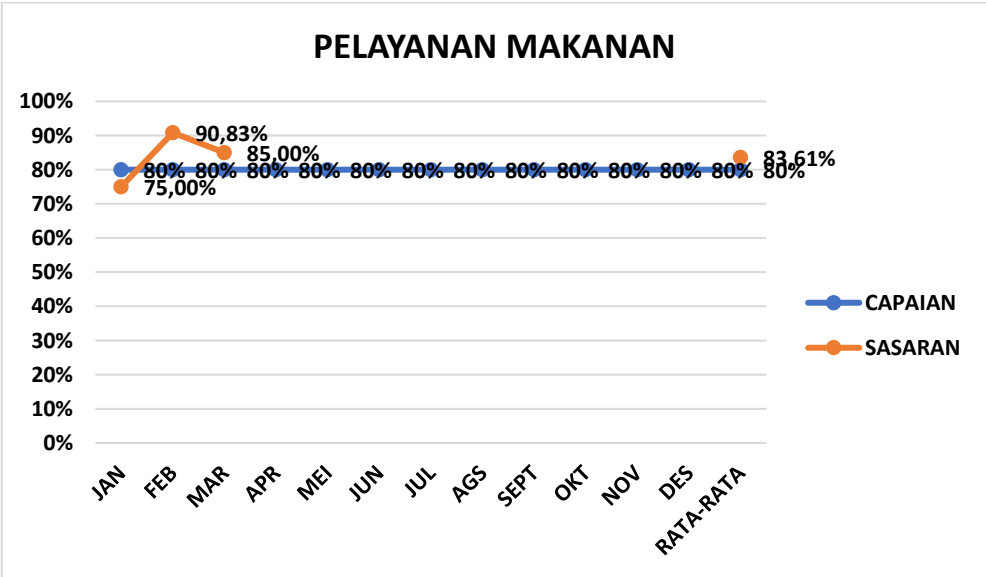
Tabel 4.1.1.1 Lingkungan Rumah Sakit

PROBLEM	Persentasi kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan belum mencapai 100%.
STEP	Memonitor berkelanjutan dalam mempertahankan atau meningkatkan kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan
PLAN	1. Rencana: Mengetahui kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan di unit secara berkesinambungan 2. Harapan Seluruh staf patuh dalam pengendalian infeksi lingkungan di unit sehingga target kepatuhan dapat dicapai. 3. Tindakan a. Melakukan audit pengendalian infeksi lingkungan di unit secara berkesinambungan. b. Meningkatkan pelaksanaan edukasi dan sosialisasi tentang pengendalian infeksi lingkungan di unit. c. Koordinasi dengan IPCLN di unit untuk meningkatkan kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan di unit.
DO	Kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan mencapai 100%
STUDY	1. Rerata kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan bulan Maret tahun 2025 yaitu sebesar 70,94% belum mencapai

	sasaran 80%. 2. Staff belum cukup baik dalam melakukan pengendalian kebersihan lingkungan. 3. Masih ditemukan beberapa area perawatan yang berdebu, kotor, dan tidak rapi serta ruangan perawatan bau tidak enak 4. CS kurang detail dalam pembersihan sehingga saat disupervisi ditemukan area bed dan nakas tampak kotor, lantai masih banyak rambutnya, dan lantai lengket 5. Masih ditemukan troli tindakan yang terdapat bercak noda darah 6. Masih ditemukan linen infeksius yang terletak dilantai 7. Masih ditemukan area kamar pasien atau kamar mandi pasien yang masih kotor dan berbau
ACTION	1. Kolaborasi dengan tim umum terkait pengadaan sumber daya pembersihan lingkungan dengan baik sesuai dengan standart 2. Beri feedback pada hasil temuan. 3. Beri teguran saat melakukan monitoring pengendalian infeksi lingkungan di unit. 4. Monitoring pembersihan dan disinfeksi permukaan lingkungan yang berisiko tinggi

b) Pelayanan Makanan

Gambar 4.1.1.2 Pelayanan Makanan



Interpretasi : Pada gambar 4.1.1.2 diketahui bahwa rerata pelayanan makanan di bulan Maret 2025 sebesar 85% dan sudah mencapai standart 80%.

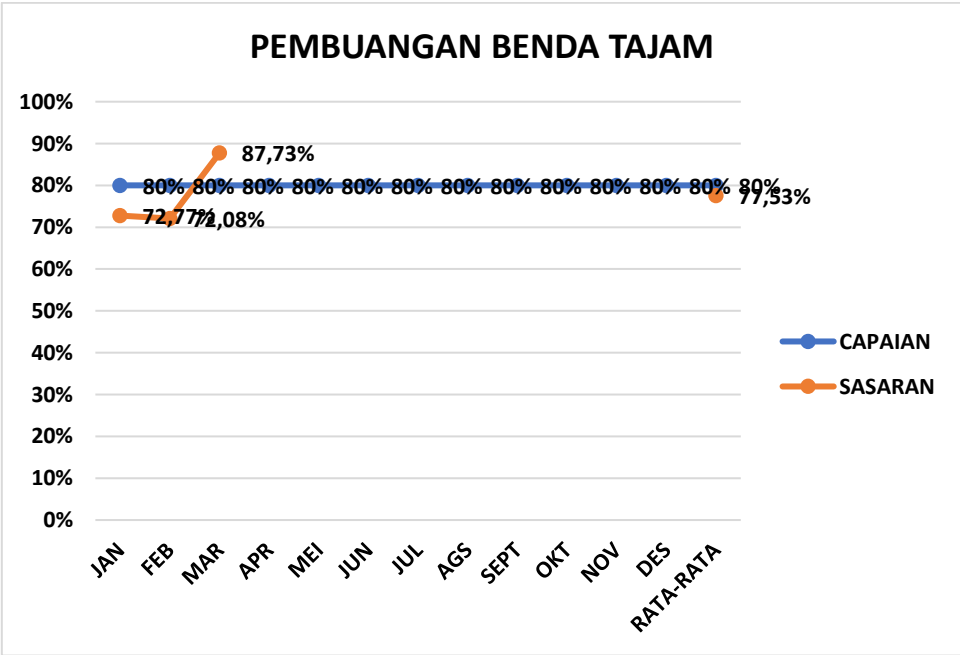
Tabel 4.1.1.2 Pelayanan Makanan

PLAN	Meningkatkan kepatuhan pelayanan makanan di rumah sakit hingga mencapai target 100%.
DO	1. Monitoring kepatuhan pelayanan makanan menggunakan form supervisi 2. Audit kebersihan tangan dan penggunaan APD menggunakan form audit
STUDY	1. Rerata kepatuhan pelayanan makanan bulan Maret tahun

	2025 adalah 85%. 2. Masih ditemukan petugas yang tidak menggunakan APD sesuai standart 3. Ditemukan staff dapur tidak melakukan cuci tangan sebelum melakukan penyiapan makanan, 4. Ditemukan makanan yang sudah masak, tidak ditutup. 5. Ditemukan hewan rodent di area dapur terutama di AC
ACTION	1. Beri <i>feedback</i> hasil temuan 2. Koordinasi dengan CS <i>pantry</i> terkait kebersihan ruang dapur dan gizi 3. Monitoring kebersihan tangan dan penggunaan APD di dapur melalui supervise dan lembar audit

c) Pembuangan Benda Tajam

Gambar 4.1.1.3 Pembuangan Benda Tajam



Interpretasi : Pada gambar 4.1.1.3 diketahui bahwa rerata pembuangan benda tajam di bulan Maret 2025 sebesar 87,73% dan belum mencapai standart 80%.

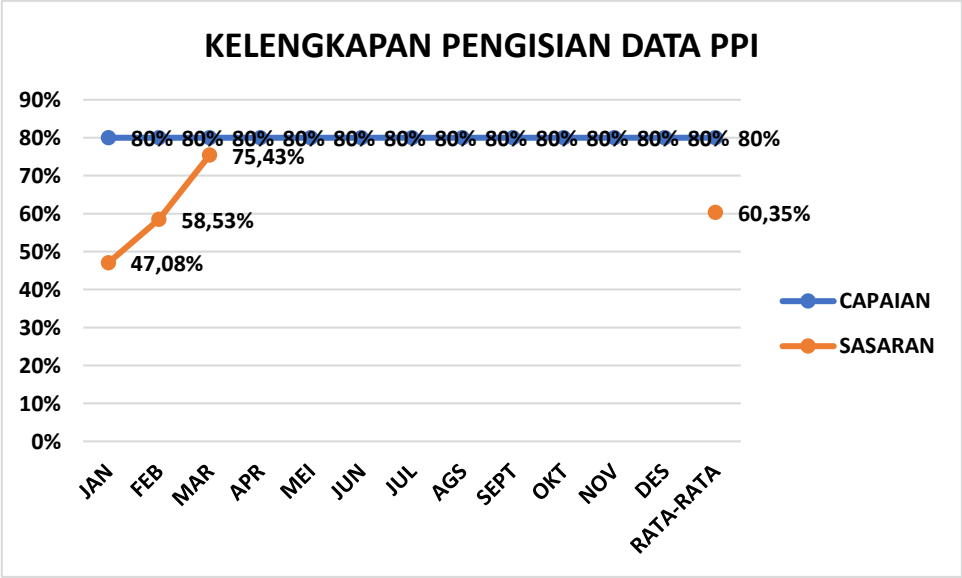
Tabel 4.1.1.3 Pembuangan Benda Tajam

PROBLEM	Persentase kepatuhan pembuangan limbah benda tajam belum mencapai 100%
STEP	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya pembuangan jarum dan benda tajam untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan serta mengurangi risiko tertusuk jarum pada petugas.
PLAN	1. Rencana: Mengetahui kepatuhan pembuangan jarum dan benda tajam di unit secara berkesinambungan 2. Harapan Seluruh staf patuh dalam pembuangan sampah jarum dan benda tajam di unit sehingga target kepatuhan dapat dicapai.

	3. Tindakan - Melakukan audit pembuangan jarum dan benda tajam di unit secara berkesinambungan. - Melaksanakan edukasi dan sosialisasi tentang pembuangan jarum dan benda tajam di unit. - Koordinasi dengan IPCLN di unit untuk meningkatkan kepatuhan pembuangan jarum dan benda tajam di unit.
DO	Kepatuhan pembuangan jarum dan benda tajam meningkat hingga mencapai 100%
STUDY	1. Rerata kepatuhan pembuangan jarum dan benda tajam bulan Maret tahun 2025 yaitu sebesar 87,73%, 2. Ditemukan <i>safety box</i> yang tidak segera dibuang saat $\frac{3}{4}$ penuh 3. Ditemukan <i>safety box</i> tidak menggantung di unit pelayanan IRNA dan IRJA
ACTION	1. Review kepada staf terkait pembuangan jarum dan benda tajam. 2. Lakukan <i>supervise</i> terhadap jumlah stok <i>safety box</i> di area pelayanan yang ditunjukkan dengan bukti <i>spreedshet</i> jumlah kebutuhan dan jumlah pemakaian di all lantai 3. Beri <i>feedback</i> pada hasil temuan. 4. Beri teguran saat melakukan monitoring pembuangan jarum dan benda tajam di unit.

d) Kelengkapan Penginputan Data Surveilans

Gambar 4.1.1.4 Kelengkapan Penginputan Data Surveilans

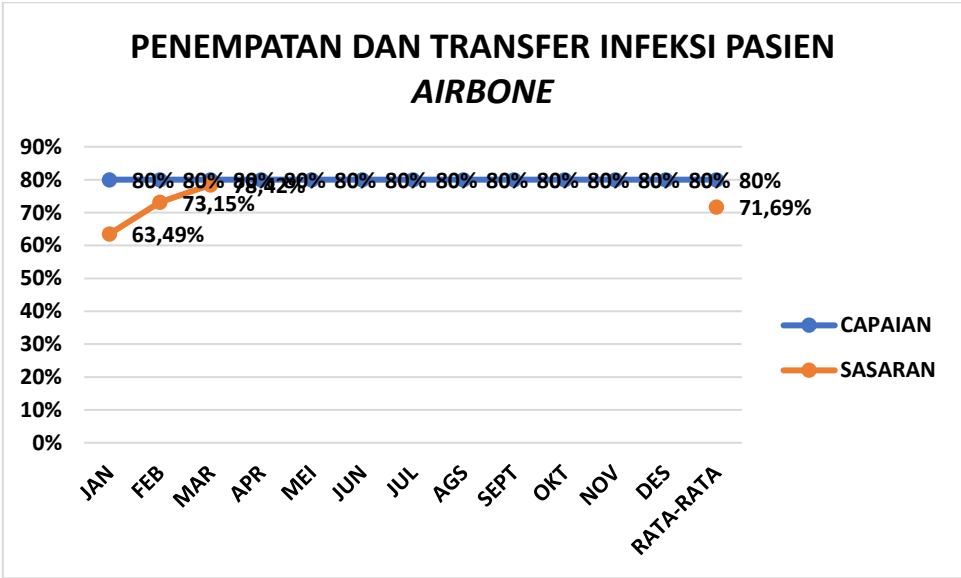


Interpretasi : Pada gambar 4.1.1.4 diketahui bahwa rerata kelengkapan penginputan data surveilans di bulan Maret 2025 sebesar 75,43% dan belum mencapai standart 80%.

Tabel 4.1.1.4 Kelengkapan Penginputan Data Surveilans

PROBLEM	Persentase kelengkapan penginputan data surveilans bulan Maret tahun 2025 sebesar 75,43% dan belum memenuhi target 80%
STEP	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya pelaporan dan penginputan hasil serta temuan di unit terkait surveilans HAI's dan monitoring kewaspadaan isolasi.
PLAN	1. Rencana: Mengetahui kepatuhan kelengkapan penginputan data surveilans secara berkesinambungan 2. Harapan Seluruh IPCLN dan PIC PPI unit melakukan penginputan data surveilans secara <i>real time</i> dan <i>ontime</i> sehingga target kepatuhan dapat tercapai. 3. Tindakan a. Melakukan sosialisasi kepada seluruh IPCLN dan PIC PPI terhadap pelaporan melalui web PPI https://sites.google.com/view/komite-ppi-rsph-sukorejo b. Berkolaborasi dengan kepala ruang, kepala bidan dan SDM terkait kepatuhan IPCLN dan PIC PPI dalam melakukan kepatuhan penginputan data surveilans dan monitoring kewaspadaan isolasi.
DO	Kepatuhan kelengkapan penginputan data surveilans belum mencapai target 80%.
STUDY	1. Rerata kepatuhan kelengkapan penginputan data surveilans di tahun 2025 di bulan Maret 2025 sebesar 75,43 % dan belum memenuhi standart. 2. Unit dengan kelengkapan penginputan data surveilans secara <i>on time</i> dan <i>real time</i> dari unit IRNA 2A 3. Ketidakepatuhan kelengkapan penginputan data surveilans disebabkan adanya, a. Banyaknya jumlah kunjungan yang mengakibatkan IPCLN / PIC PPI tidak melakukan penginputan data b. Banyaknya jumlah tanggal merah
ACTION	1. Lakukan evaluasi pengisian form PPI by web setiap bulan 2. Lakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap kelengkapan data yang telah di isi dengan melibatkan Karu dan Kabid terkait. 3. Lakukan sosialisasi dan edukasi ulang kepada PIC PPI yang belum faham 4. Buatkan SPO pengisian data surveilans dan monitoring kewaspadaan isolasi 5. Lakukan audit per unit dengan identifikasi dan berikan award pada unit dengan tingkat kepatuhan tinggi dalam pelaporan 6. Berikan feedback hasil audit dan monitoring 7. Berikan teguran pada IPCLN dan PIC PPI yang tidak patuh dalam melakukan pelaporan

- b. Kewaspadaan Transmisi
- a) Penempatan dan Transfer Infeksi Pasien *Airbone*
- Gambar 4.1.1.5 Penempatan dan Transfer Infeksi Pasien *Airbone*



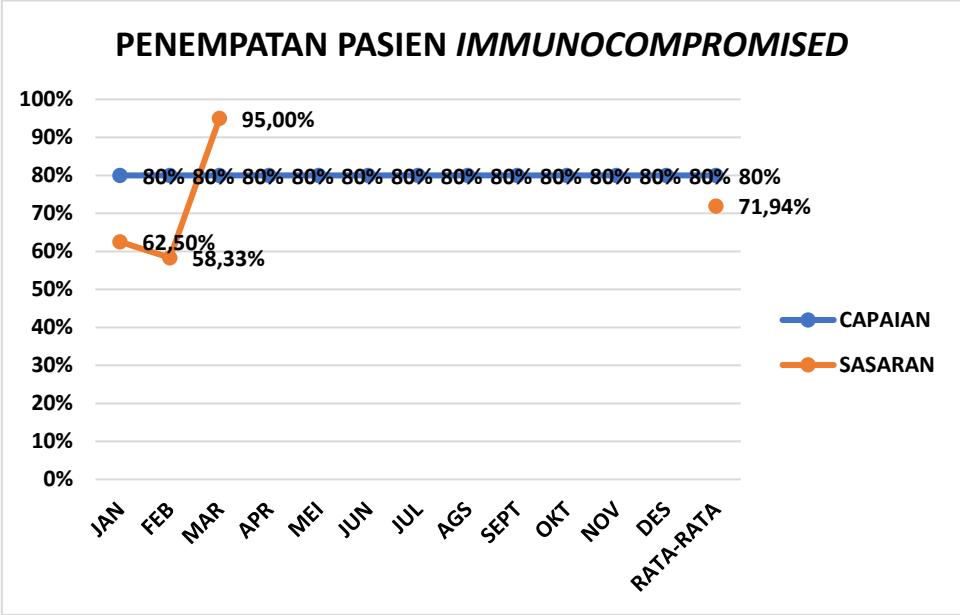
Interpretasi : Pada gambar 4.1.1.5 diketahui bahwa rerata penempatan dan transfer infeksi pasien *airbone* di bulan Maret 2025 sebesar 78,42% dan belum mencapai standart 80%.

Tabel 4.1.1.5 Penempatan dan Transfer Infeksi Pasien *Airbone*

PROBLEM	Persentase kepatuhan penempatan dan transfer infeksi pasien <i>airbone</i> belum mencapai 100%
STEP	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya kepatuhan dalam penempatan dan transfer infkesi pasien <i>airbone</i> untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan serta mengurangi risiko tertularnya petugas dalam melakukan perawatan terhadap pasien dengan resiko penulara secara <i>airbone</i>
PLAN	1. Rencana: Mengetahui kepatuhan penempatan dan transfer infeksi pasien <i>airbone</i> di unit secara berkesinambungan 2. Harapan Seluruh staf patuh dalam kepatuhan penempatan dan transfer infeksi pasien <i>airbone</i> di unit sehingga target kepatuhan dapat dicapai. 3. Tindakan a. Melakukan audit kepatuhan penempatan dan transfer infeksi pasien <i>airbone</i> di unit secara berkesinambungan. b. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi tentang kepatuhan penempatan dan transfer infeksi pasien <i>airbone</i> c. Koordinasi dengan IPCLN di unit untuk meningkatkan kepatuhan kepatuhan

	penempatan dan transfer infeksi pasien <i>airbone</i> baik antar staf, pasien, keluarga bahkan hingga ke pengunjung.
DO	Kepatuhan penempatan dan transfer infeksi pasien <i>airbone</i> belum mencapai 80%
STUDY	1. Rerata kepatuhan penempatan dan transfer infeksi pasien <i>airbone</i> bulan Maret tahun 2025 yaitu sebesar 78,42%, 2. Masih ditemukan kurangnya edukasi penempatan dan transfer infeksi pasien <i>airbone</i> kepada pasien sehingga sering keluar masuk pengunjung yang tidak menggunakan masker, tidak menutup pintu kembali 3. Masih ditemukan pengunjung keluar masuk ke dalam ruang isolasi, 4. Ditemukan beberapa rekam medis tidak tertulis edukasi pasien dan keluarga terkait tata tertib ruang isolasi, 5. Ditemukan staff IRNA 2A tidak menggunakan APD yang sesuai seperti masker N95
ACTION	1. Review kepada staf terkait kepatuhan penempatan dan transfer infeksi pasien <i>airbone</i>. 2. Lakukan koordinasi dengan Karu IRNA 2A untuk melakukan re-sosialisasi kembali kepada staff terhadap kepatuhan penempatan dan transfer infeksi pasien <i>airbone</i> yang dibuktikan dengan terisinya form edukasi terkait tata tertib ruang isolasi 3. Lakukan edukasi kepada keluarga dan pengunjung isolasi untuk tidak keluar masuk ruang isolasi secara bebas, penggunaan APD serta etika batuk yang dibuktikan dengan edukasi kelompok (baik berupa foto atau video) 4. Aktivkan CCTV diarea R. Isolasi dan lakukan kolaborasi dengan satpam RS untuk penertiban pengunjung di area ruang Isolasi, 5. Lakukan sosialisasi 6. Beri <i>feedback</i> pada hasil temuan, 7. Beri teguran pada unit yang tidak melakukan kepatuhan penempatan dan transfer infeksi pasien <i>airbone</i> dengan tepat

b) Penempatan Pasien *Immunocomprissed*
Gambar 4.1.1.6 Penempatan Pasien *Immunocomprissed*



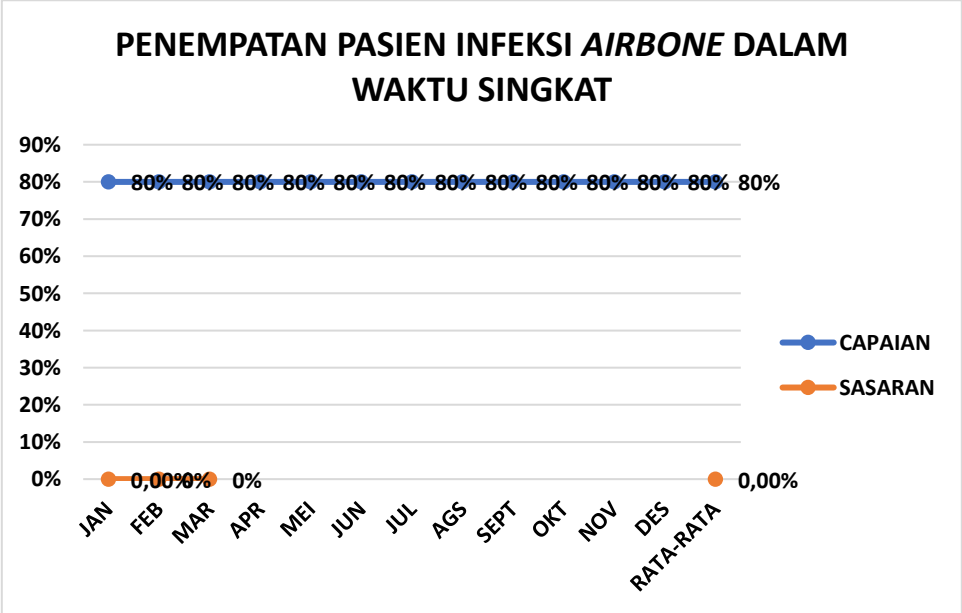
Interpretasi : Pada gambar 4.1.1.6 diketahui bahwa rerata kepatuhan penempatan pasien *immunocomprissed* di bulan Maret 2025 sebesar 95% dan sudah mencapai standart 80%.

Tabel 4.1.1.5 Penempatan Pasien *Immunocomprissed*

PROBLEM	Persentase kepatuhan penempatan pasien <i>immunocomprissed</i> belum mencapai 100%
STEP	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya kepatuhan penempatan pasien <i>immunocomprissed</i> untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan serta mengurangi risiko tertularnya petugas dalam melakukan perawatan terhadap pasien dengan resiko penulara secara <i>airbone</i> .
PLAN	1. Rencana: Mengetahui kepatuhan penempatan pasien <i>immunocomprissed</i> di unit secara berkesinambungan 2. Harapan Seluruh staf patuh dalam kepatuhan penempatan pasien <i>immunocomprissed</i> di unit sehingga target kepatuhan dapat dicapai. 3. Tindakan a. Melakukan audit kepatuhan penempatan pasien <i>immunocomprissed</i> di unit secara berkesinambungan. b. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi tentang kepatuhan kepatuhan penempatan pasien <i>immunocomprissed</i> c. Koordinasi dengan IPCLN di unit untuk meningkatkan kepatuhan penempatan pasien <i>immunocomprissed</i> baik antar staf, pasien, keluarga bahkan hingga ke

	pengunjung.
DO	Kepatuhan penempatan pasien <i>immunocomprised</i> belum mencapai 80%
STUDY	1. Rerata kepatuhan penempatan pasien <i>immunocomprised</i> bulan Maret tahun 2025 yaitu sebesar 95%, 2. Masih ditemukan kurangnya edukasi penempatan pasien <i>immunocomprised</i> kepada pasien dan keluarga sehingga sering keluar masuk pengunjung yang tidak menggunakan masker, 3. Terdapat penurunan penggunaan ruang <i>immunocomprised</i> pada pasien non infeksius.
ACTION	1. Review kepada staf terkait kepatuhan penempatan pasien <i>immunocomprised</i> . 2. Lakukan koordinasi dengan Karu IRNA 2A untuk melakukan re-sosialisasi kembali kepada staff terhadap kepatuhan penempatan pasien <i>immunocomprised</i> yang dibuktikan dengan terisinya form edukasi terkait tata tertib ruang isolasi 3. Lakukan edukasi kepada keluarga dan pengunjung isolasi untuk tidak keluar masuk ruang isolasi secara bebas, penggunaan APD serta etika batuk yang dibuktikan dengan edukasi kelompok (baik berupa foto atau video) 4. Aktivkan CCTV diarea R. Isolasi dan lakukan kolaborasi dengan satpam RS 5. Beri <i>feedback</i> pada hasil temuan. 6. Beri teguran pada unit yang tidak melakukan kepatuhan penempatan pasien <i>immunocomprised</i>

c) Penempatan Pasien Infeksi *Airbone* dalam Waktu Singkat
Gambar 4.1.1.7 Penempatan Pasien Infeksi *Airbone* dalam Waktu Singkat



Interpretasi : Pada gambar 4.1.1.7 diketahui bahwa rerata kepatuhan penempatan pasien infeksi *airbone* dalam waktu singkat di bulan Maret 2025 sebesar 0% dan belum mencapai standart 80%.

Tabel 4.1.1.7 Penempatan Pasien Infeksi *Airbone* dalam Waktu Singkat

PROBLEM	Persentase kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat belum mencapai 100%
STEP	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit IGD dan rawat inap mengenai pentingnya kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan serta mengurangi risiko tertularnya petugas dalam melakukan perawatan terhadap pasien dengan resiko penulara secara <i>airbone</i>
PLAN	1. Rencana: Mengetahui kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat di unit secara berkesinambungan. 2. Harapan Seluruh staf patuh dalam kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat di unit sehingga target kepatuhan dapat dicapai. 3. Tindakan a. Melakukan audit kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat di unit secara berkesinambungan, b. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi tentang kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat, c. Koordinasi dengan IPCLN di unit untuk meningkatkan kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat baik antar staf, pasien, keluarga bahkan hingga ke pengunjung.
DO	Kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat belum mencapai 80%.
STUDY	1. Rerata kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat bulan Maret tahun 2025 yaitu sebesar 0%, 2. Ditemukan data sebesar 0% dikarenakan kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat tidak adapat terukur secara <i>real time</i>
ACTION	1. Review kepada staf terkait kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat. 2. Lakukan koordinasi dengan Karu IGD untuk melakukan re-sosialisasi kembali kepada staff terhadap kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat yang dibuktikan dengan terisinya form edukasi terkait tata tertib

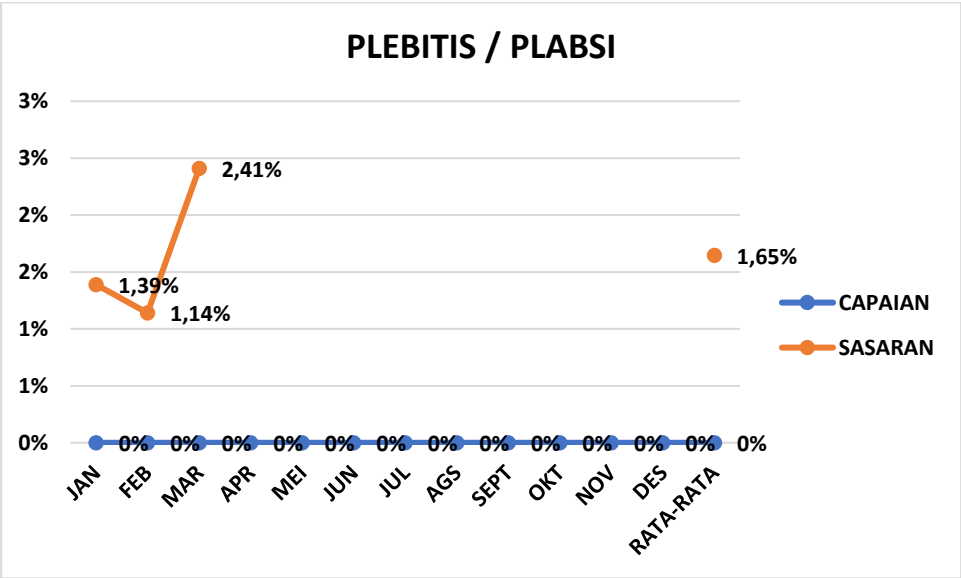


	ruang isolasi 3. Lakukan audit secara berkesinambungan Bersama IPCLN IGD 4. Beri <i>feedback</i> pada hasil temuan. 5. Beri teguran pada unit yang tidak melakukan kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat.
--	---

4.1.2 Audit *Bundle* HAI's PPI

a. *Bundle Phlebitis*

Gambar 4.1.2.1 Phlebitis



Interpretasi : Pada gambar 4.1.2.1 diketahui bahwa rerata kejadian phlebitis di bulan Maret 2025 sebesar 2,41% dan belum mencapai standart 0%.

Tabel 4.1.2.1 Phlebitis

No	Bulan	Unit	Jumlah Phlebitis
1	Januari	IRNA 3A	11
		IRNA 3B	3
		IRNA 2A	4
		IRNA 2B	2
		MATERNITAS	0
		NEONATOLOGI	0
		ICU	0
2	Februari	IRNA 3A	0
		IRNA 3B	3
		IRNA 2A	7
		IRNA 2B	6
		MATERNITAS	0
		NEONATOLOGI	1
		ICU	0
3	Maret	IRNA 3A	6
		IRNA 3B	7
		IRNA 2A	6
		IRNA 2B	4
		MATERNITAS	2
		NEONATOLOGI	2
		ICU	0
		IRJA	7
		TOTAL	

Interpretasi : Pada gambar 4.1.2.1 diketahui kejadian plebitis terbanyak di unit IRNA 3B sebesar 7 kejadian dan IRJA 7 kejadian dengan rincian rerata semua pasien dewasa.

Tabel 4.1.2.2 PDSA Phlebitis

PLAN	1. Melaksanakan <i>bundles phlebitis</i> sesuai SPO 2. Monitoring dan evaluasi oleh IPCLN 3. Supervisi oleh IPCN
------	--

DO	1. Surveilans phlebitis dilakukan menggunakan form <i>surveilans</i> 2. Monitoring kepatuhan <i>bundles</i> dilakukan menggunakan <i>google form</i>
STUDY	1. Rata-rata kejadian phlebitis pada bulan Maret 2025 sebesar 2,41%. 2. Jumlah kejadian phlebitis terbanyak pada bulan Maret 2025 terjadi pada unit IRNA 3B dan IRJA 3. Ketidakpatuhan kebersihan tangan sebelum melakukan tindakan dan teknik aseptik yang tidak tepat menjadi penyebab rendahnya kepatuhan <i>bundles insersi</i> phlebitis. 4. Kenaikan kasus phlebitis dikarenakan meningkatnya proses perawatan luka infus oleh petugas dan dari sisi internal pasien sendiri yang menjaga agar lokasi infus tidak bengkak. 5. Risiko pembengkakan area insersi meningkat karena semakin tingginya penggunaan obat seperti furosemid, dobutamin, dan nicarpidin yang dimasukkan ketubuh pasien melalui syringe pump serta kondisi fisik pasien (ada penyakit penyerta seperti DM, gagal jantung dll). 6. Ditemukan pasien phlebitis di IRJA terjadi pada pasien post MRS dari unit IRNA 2B (2 orang), IRNA 3A (1 orang) dan IRNA 2A (4 orang) dengan rendahnya edukasi phlebitis pada pasien KRS di unit rawat inap oleh staff perawat. 7. Jumlah phlebitis rata-rata bulan Maret terjadi pada kasus dewasa dengan case, a. Jumlah perawatan yang memanjang b. Penggunaan obat-obatan pekat (KCL, Manitol, penggunaan obat deuretik, dll) c. Pasien dengan komorbid DM d. Pasien jantung
ACTION	1. Lakukan sosialisasi kepada perawat tentang <i>bundles insersi</i> dan <i>maintenance phlebitis</i>. 2. Koordinasi dengan komite keperawatan untuk melakukan pelatihan pemasangan infus serta prosedur perawatan luka infus. 3. Lakukan monitoring dan evaluasi terhadap <i>bundles phlebitis</i> 4. Berikan <i>feed back</i> terhadap temuan



b. **Bundle IDO**

Gambar 4.1.2.1 Bundle IDO

LAPORAN DATA ANALISIS INFEKSI DAERAH OPERASI TAHUN 2025										PT. DISA PRIMA MEDIKA															
No	Bulan/Tanggal Pelaporan	Inisial Pasien	No RM	Unit	Usia	Tgl/Uam MRS	DPJP	Penjamin	Tgl Operasi	Da Operasi & Tindakan Operasi	Tim Operasi					Kontrol ke	Riwayat Rawat Luka Post Op	Hasil Penunjang Abnormal		Terapi Saat ILO	Assesmen lain	Praduga Penyebab ILO	RTL	Total Kejadian IDO	
											Ast Op	dr.An	Ast. An	Instrumen	Onkolog			Saat Op	Saat IDO						
Januari																									
Februari																									
1	2/11/2025	NY. ZHILA QITRIYAH	113569	POLI OB/GYN	27 TH	2/4/2025	DR. SANTOSO	BPJS KLS 1	2/4/2025	01P0AB0 UK 40-41 MDD DG SEVERE QUIDO DG LETAK OBLIQ + LILTAN TALU PUSAT	EDO	HARLI	RIZKI	KIKIS	SILFI	-	Ada rembesan di area balutan, terdapat pusah dan berbau tidak sedap	Hb : 12.2 L : 8.400 T : 198.000	-	VIT C 2X1 ONCIVA 1X1	-	Obesitas 55kg ke 93 kg	MENJAGA SALURAN LUKA ASAR TETAP KERING BILA TERJADI REMBESAN MAHA DIBANTI MAKAN YANG BANYAK TIDAK BOLEH TARAK MENURUNKAN BB ATAU MENJAGA BB	1	
2	2/28/2025	NY. KHOIRO UMAH	081524	28	54 TH	1/16/02/2025 1/26/02/2025	DR. ROSY ZAKI	BPJS KLS 3	1/16/02/2025 1/26/02/2025	1 APPENDICITIS AKUT II ILEUS OBSTRUKTIF	KIKIS EDO	BOBI HERU	ROHMAN AGUNG	ERD ANTOK	DANANG SILFI	Kontrol poli ke 1 post MRS pertama tanggal 21/02/2025 MRS ulang tanggal 26/02/2025 Kontrol poli ke 1 post MRS ke dua tanggal 06/03/2025	Rawat luka terbuka	OP KE 1 Hb 12,4 L 8.900 T 243.000 GOS 340 OP KE 2 Hb 11,5 L 23.100 T 482.000 GOS 428	-	Ranitidin 2x1 Ondans 3x1 Sempaglik 3x1 Metronidazole 3x1 Mepopenem 3x1	Obat KRS Cefixim 2x200 mg Etorwel 2x1 OMZ 2x1 Batafil 1x1	GDA tinggi	RL luka khusus oleh tenaga ahli Dai DM Penggunaan obat-obatan harus di minum secara teratur Rawat luka sap 2 hari sekali di RS PWS	2	
Maret																									
1	3/5/2025	RUL WIDAYATI	113570	POLI BEDAH	34 TH	2/27/2025	DR. ROSY ZAKI	BPJS KLS 1	2/27/2025	S APPENDICITIS AKUT	EDO	BOBI	AGUNG	KIKIS	DANANG	Kontrol I 05/03/2025	-	Hb 14,1 L 11.700 T 343.000 GOS 118	-	Obat post kontrol poli Cefixim 2x100 Ibu profen 2x100 OMZ 2x1	Rawat luka bersih menggunakan outsel Setiap luka rembes wajib di ganti	Mobilisasi sedikit Gizi yang dikonsumsi kurang (protein) Konsumsi air putih kurang	Rawat luka bersih di rumah dengan cairan NS Banyak mengonsumsi protein hewani Banyak melakukan mobilisasi (tidak melakukan aktivitas berat) Lakukan kompres hangat bila demam	3	
2	3/5/2025	FARIDA NURDIANA	035075	POLI BEDAH	46 TH	2/24/2025	DR. RIPTA	BPJS KLS 3	2/25/2025	S APPENDICITIS AKUT + S CHOLELITIASIS	WAFI	HARLI	RIZKI	FENDRA	NIMO	Kontrol I 05/03/2025	-	-	-	Obat post kontrol poli Thiamphenicol 4x1 Metronidazole 3x1 Atam Mefenamat 3x1	Rawat luka bersih Setiap luka rembes wajib di ganti	Mobilisasi sedikit Gizi yang dikonsumsi kurang (protein) / banyak makan	Rawat luka bersih di rumah dengan cairan NS Banyak mengonsumsi protein hewani melakukan mobilisasi (tidak melakukan aktivitas berat)	4	
3	2/7/2025	RATNA DEWI	090619	POLI BEDAH	42 TH	2/23/2025	DR. ROSY ZAKI	BPJS KLS 1	2/24/2025	MAMAE ABRERAN D / EXCISI	WAFI	HERU	ROHMAN	FENDRA	DANANG	Kontrol I 28/02/2025 Kontrol II 07/03/2025	Keluar darah pada saat kontrol ke dua	Hb 12,9 L 5.800 T 185.000 Hasil PA : Jarak	keluar gumpalan darah di ketiak "area insisi"	Ibu profen 2x1 Cefixim 2x100 mg	Luka tidak di jahit, di tampun menggunakan kasa Luka diberikan outsel, dan ditutup kasa steril	Kurangnya mobilisasi	Rawat luka sap 2 hari sekali, Luka yang di aff jahitan diberi dan di tampun kassa Evaluasi kembali 14/03/2025	5	

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA			LAPORAN DATA ANALISIS INFEKSI DAERAH OPERASI TAHUN 2025															 PT. DISA PRIMA MEDIKA						
No	Bulan/Tanggal Pelaporan	Inisial Pasien	No RM	Unit	Usia	Tgl/Jam MRB	DPJP	Penjamin	Tgl Operasi	Dx Operasi & Tindakan Operasi	Tim Operasi					Kontrol ke	Riwayat Rawat Luka Post Op	Hasil Penunjang Abnormal		Terapi Saat ILO	Asesmen lain	Preduga Penyebab ILO	RTL	
											Ast Bd	dr.An	Ast An	Instrumen	Onloop			Saat Op	Saat IDO					
Januari																								
																MRS ke dua tanggal 06/03/2025								
Maret																								
1	3/5/2025	INUL WIDAYATI	113570	POLI BEDAH	34 TH	2/27/2025	DR. ROSY ZAKI	BPJS KLS 1	2/27/2025	S. APPENDICITIS AKUT	EDO	BOBI	AGUNG	KIKIS	DANANG	Kontrol I 05/03/2025	-	Hb 14,1 L 11.700 T 343.000 GDS 116	-	Obat post kontrol poli Cefixim 2x100 Ibu profen 2x100 OMZ 2x1	Rawat luka bersih menggunakan cutisel Setiap luka rembes wajib di ganti	Mobilisasi sedikit Gizi yang dikonsumsi kurang (protein) Konsumsi air putih kurang	Rawat luka bersih di rumah dengan cairan NS Banyak mengkonsumsi protein hewani Banyak melakukan mobilisasi (tidak melakukan aktivitas berat) Lakukan kompres hangat bila demam	
2	3/5/2025	FARIDA NURDIANA	035075	POLI BEDAH	48 TH	2/24/2025	DR. RIFTA	BPJS KLS 3	2/25/2025	S. APPENDICITIS AKUT + S. CHOLELITIASIS	WAFI	HARLI	RIZKI	FENDRA	NIKO	Kontrol I 05/03/2025	-	-	-	Obat post kontrol Thiamphenicol 4x1 Metronidazole 3x1 Asam Mefenamat 3x1	Rawat luka bersih Setiap luka rembes wajib di ganti	Mobilisasi sedikit Gizi yang dikonsumsi kurang (protein) / tarak makan	Rawat luka bersih di rumah dengan cairan NS Banyak mengkonsumsi protein hewani melakukan mobilisasi (tidak melakukan aktivitas berat)	
3	3/7/2025	RATNA DEWI	060619	POLI BEDAH	42 TH	2/23/2025	DR. ROSY ZAKI	BPJS KLS 1	2/24/2025	MAMAE ABRERAN D / EXCISI	WAFI	HERU	ROHMAN	FENDRA	DANANG	Kontrol I 28/02/2025 Kontrol II 07/02/2025	Keluar cloth pada saat kontrol ke dua	Hb 12,9 L 5.800 T 185.000 Hasil PA : Jinak	keluar gumpalan darah di ketak "ares insisi"	Ibu profen 2x1 Cefixim 2x100 mg	Luka tidak di jahit, di tampon menggunakan kasa Luka diberikan cutisel, dan ditutup kasa steril	Kurangnya mobilisasi	Rawat luka tiap 2 hari sekali, Luka yang di aft jahitan diberi dan di tampon kasa Evaluasi kembali 14/03/2025	
4	3/24/2025	LUTFIANINGSIH	097605	IRNA 2A	35 TH	3/23/2025	DR. SANTOSO DR. ROSY ZAKI	BPJS KLS 1	3/12/2025	MIOMA UTERI	EDO	HARLI	RIZKI	EKO	NIKO	Kontrol I 20/03/2025	Keluar push diantara jahitan pasien ketika di bawah ke IGD	Hb 10,1 L 8.200 T 596.000 GDS 70 PPT 13,0 APPT 30,5 PDST op Hb 9,2 L 10.500 T 567.000	Hb 10,3 L 15.100 T 540.000	Ceftriaxon 2x1 Metronidazol 3x1 Santagesik 3x1 Ranitidin 2x1 Obat TB Ritampirin 0-8-400mg Pirazinamid 0-0-500mg Isoniazid 0-0-1 Racikan etambutol R.O.600mg	Rawat luka menggunakan cutisel tiap pagi atau bila rembes	Gizi pasien kurang	Rawat luka tiap pagi Konsumsi obat TB	

Interpretasi : Berdasarkan gambar 4.1.2.3 dapat diketahui jumlah Bundle IDO di bulan Maret sebanyak 3 kasus laparatomi, dan 1 kasus eksisi.

Link Rekap analisa IDO 2025 :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B0O4PmS-oovztJNlJw_Te2hQkENP-MWt/edit?usp=sharing&ouid=112970937896793169786&rtpof=true&sd=true

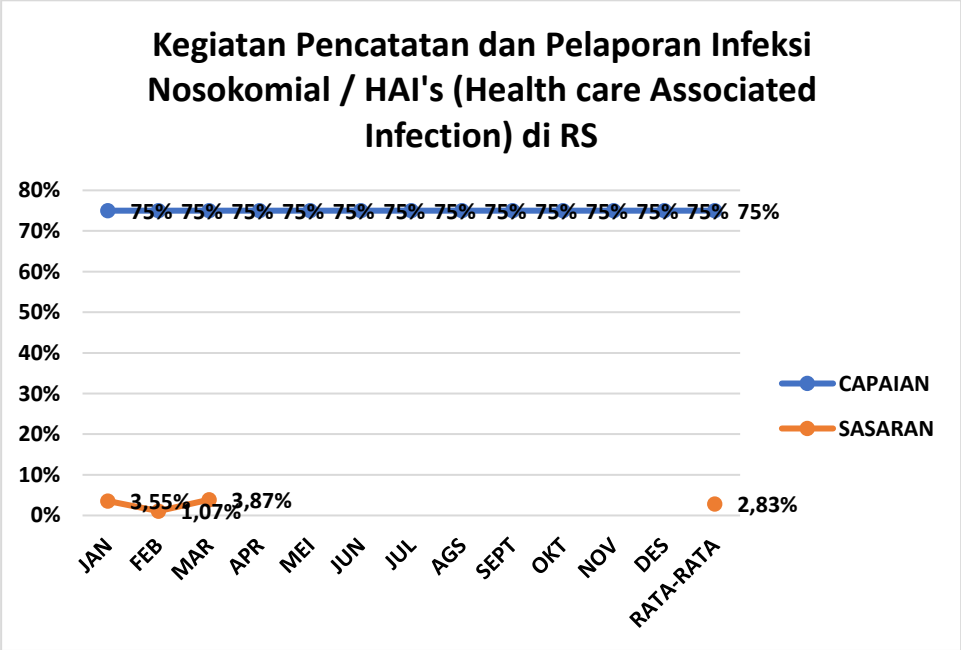
Tabel 4.1.2.3 PDSA Bundle IDO

PLAN	1. Melaksanakan <i>bundles IDO</i> sesuai SPO 2. Monitoring dan evaluasi oleh IPCLN 3. Supervisi oleh IPCN
DO	1. Surveilans IDO dilakukan menggunakan form <i>surveilans</i> 2. Monitoring kepatuhan <i>bundles</i> dilakukan menggunakan <i>google form</i>
STUDY	1. Kejadian IDO pada bulan Maret 2025 sebanyak 4 kejadian 2. Pelaporan jumlah kejadian IDO pada bulan Maret 2025 dari unit IKO yang disebabkan oleh kondisi pasien 3. Kejadian IDO pada bulan Maret 2025 di sebabkan oleh, a. Faktor dari pasien : tidak mau melakukan mobilisasi, tidak mau mengkonsumsi tinggi protein (tarak makan), ketika dilakukan pembedahan di temukan organ yang sudah perforasi b. Faktor penyakit : terdapat 1 pasien dengan TB Abdomen
ACTION	1. Beri feedback hasil temuan 2. Monitor pelaksanaan <i>bundles IDO</i> pada saat prosedur operasi maupun pada saat prosedur perawatan luka. 3. Tingkatan edukasi perawatan pasien pasca operasi untuk menghilangkan mitos-mitos masyarakat tentang operasi. 4. Koordinasi dengan pengadaan farmasi terkait cairan antiseptik untuk mandi pasien yang akan operasi serta alat cukur yang lebih berisiko rendah untuk cedera. 5. Rencanakan pelatihan khusus CS IKO terkait pembersihan lingkungan IKO 6. Koordinasi dengan dokter operator dan tim IKO lainnya terkait berjalannya <i>bundles</i> operasi SC.

4.1.3 Mutu PPI

a. Kegiatan Pencatatan dan Pelaporan HAI's

Gambar 4.1.3.1 Kegiatan Pencatatan dan Pelaporan HAI's



Interpretasi : Pada gambar 4.1.3.1 diketahui bahwa rerata kegiatan pencatatan dan pelaporan HAI's di bulan Maret 2025 sebesar 3,87% dan belum mencapai standart 75%.

Tabel 4.1.3.1 Kegiatan Pencatatan dan Pelaporan HAI's

PROBLEM	Persentasi kepatuhan kegiatan pencatatan dan pelaporan HAI's belum mencapai 100%
STEP	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya kegiatan pencatatan dan pelaporan HAI's untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan serta mengurangi risiko tertularnya petugas dalam melakukan perawatan terhadap pasien.
PLAN	1. Rencana: Mengetahui kegiatan pencatatan dan pelaporan HAI's di unit secara berkesinambungan 2. Harapan Seluruh staf patuh dalam kegiatan pencatatan dan pelaporan HAI's di unit sehingga target kepatuhan dapat dicapai. 3. Tindakan d. Melakukan audit kegiatan pencatatan dan pelaporan HAI's di unit secara berkesinambungan. e. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi tentang kepatuhan kegiatan pencatatan dan pelaporan HAI's f. Koordinasi dengan IPCLN di unit untuk meningkatkan kegiatan pencatatan dan pelaporan HAI's yang ada di unit.
DO	Kegiatan pencatatan dan pelaporan HAI's belum

	mencapai 80%
STUDY	1. Rerata kegiatan pencatatan dan pelaporan HAI's bulan Maret tahun 2025 yaitu sebesar 3,87%, 2. Masih ditemukan belum aktifnya petugas dalam melakukan pelaporan HAI's secara <i>real time</i>, 3. Masih ditemukan kejadian HAI's yang tidak dilaporkan seperti adanya praduga IDO pada pasien pasca operasi, dan kejadian phlebitis.
ACTION	1. Re-sosialisasi ulang kepada staf terkait langkah pelaporan HAI's. 2. Lakukan koordinasi dengan Karu all pelayanan untuk menghimbau IPCLN/PIC PPI unit untuk patuh dalam melaporkan kejadian HAI's dengan waktu perekapan selama 1 minggu sekali 3. Beri <i>feedback</i> pada hasil temuan. 4. Beri teguran pada unit yang tidak melakukan kepatuhan kegiatan pencatatan dan pelaporan HAI's

b. Kepatuhan Kebersihan Tangan

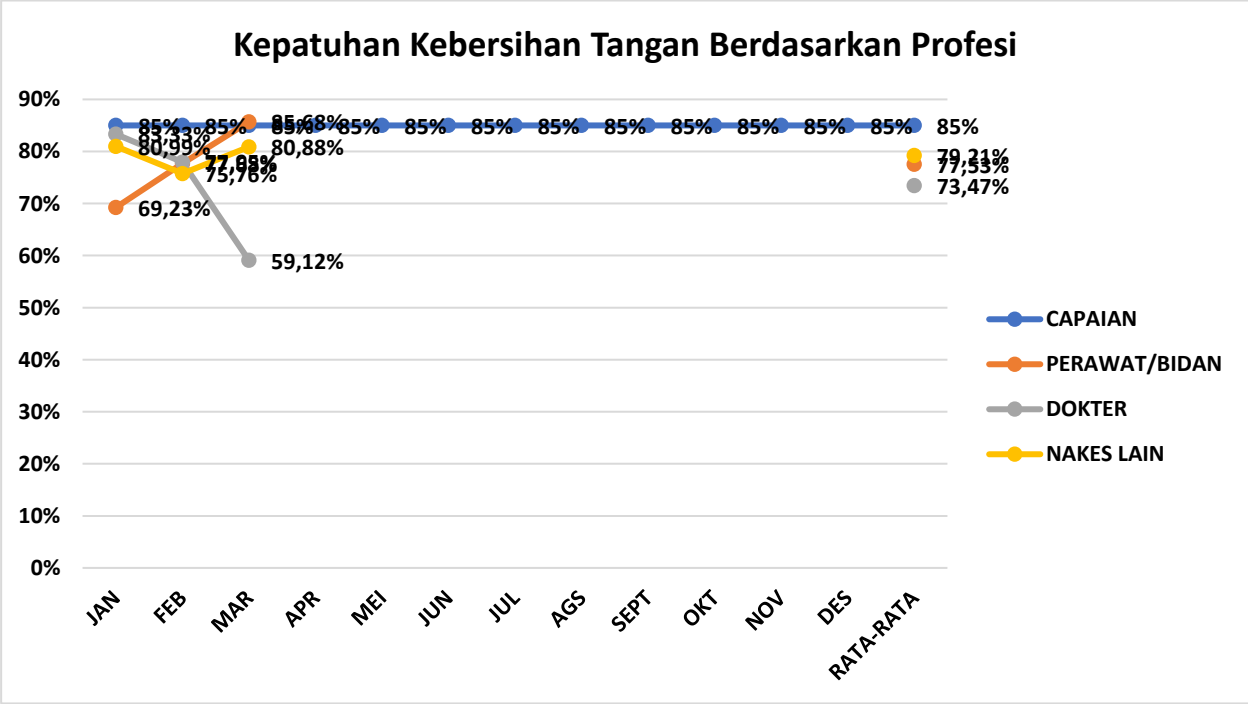
a) Berdasarkan Unit

Tabel 4.1.3.2 Kepatuhan Kebersihan Tangan

NO	INDIKATOR PENILAIAN	STANDAR T	BULAN												RATA-RATA
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	3A	85%	76,36%	80,77%	88,41%										78,57%
2	3B	85%	87,50%	44,44%	41,43%										65,97%
3	2A	85%	100%	50,00%	71,34%										75%
4	2B	85%	100%	100%	78%										100%
5	2D	85%	0%	0%	0%										0%
6	MAT	85%	80%	71,79%	68%										75,90%
7	NEO	85%	72,73%	89,02%	96%										80,88%
8	ICU	85%	100%	100%	75%										100%
9	IKO	85%	100%	44,44%	0%										72,22%
10	IGD	85%	58,57%	77,78%	84%										68,18%
11	IRJA	85%	100%	78,23%	83%										89,12%
12	CS	85%	0%	0%	0%										0%
13	As. Center	85%	0%	0%	0%										0%
14	Farmasi	85%	100%	72,41%	0%										86,21%
15	Laboratorium	85%	100%	100%	94%										100%
16	Radiologi	85%	0%	100%	0%										50%
17	Gizi dan Dapur	85%	62,50%	78,26%	97%										70,38%
18	RM / PDF	85%	0%	0%	0%										0%
19	CSSD	85%	0%	0%	0%										0%
20	LAUNDRY	85%	0%	0%	0%										0%

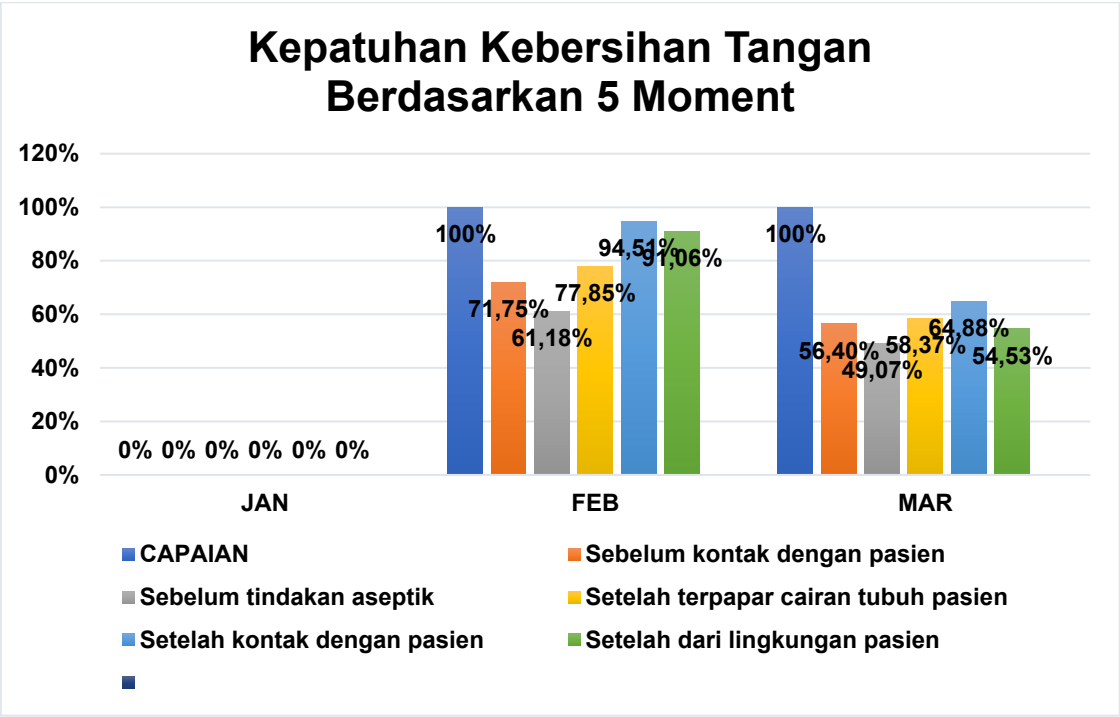
Interpretasi : Pada tabel 4.1.3.2 diketahui kepatuhan kebersihan tangan pada bulan Maret 2025 tertinggi berada pada unit Neonatologi dengan rerata 96%.

b) Berdasarkan Profesi
 Gambar 4.1.3.2 Kepatuhan Kebersihan Tangan Berdasarkan Profesi



Interpretasi : Pada gambar 4.1.3.2 diketahui bahwa rerata kepatuhan kebersihan tangan berdasarkan profesi di bulan Maret 2025 sebesar tertinggi pada profesi Perawat dengan rerata 85,68%.

c) Berdasarkan 5 Moment
 Gambar 4.1.3.2.1

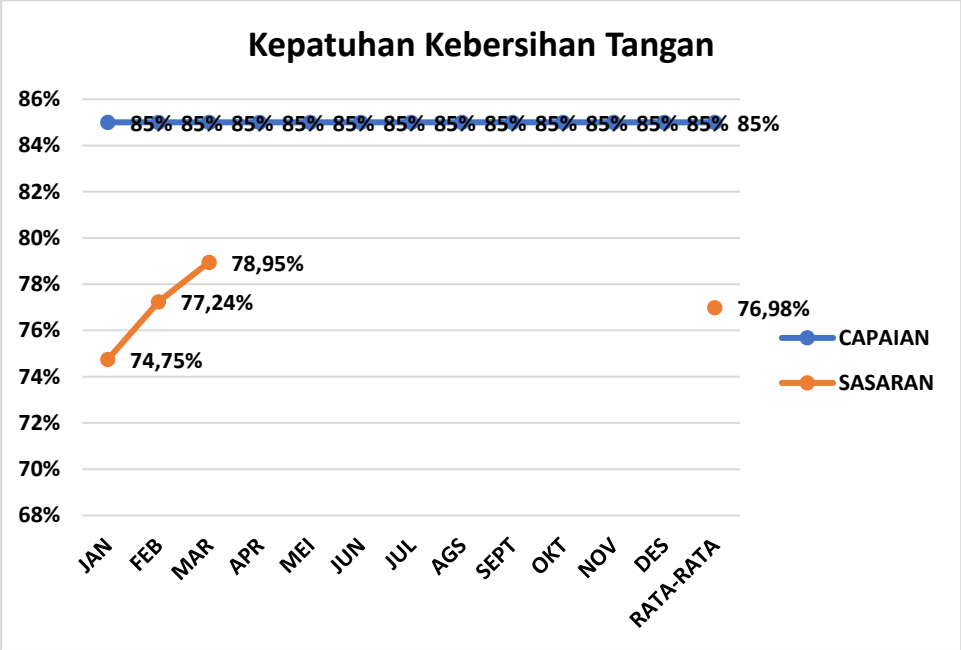


Interpretasi : Pada gambar 4.1.3.2 diketahui bahwa rerata kepatuhan kebersihan tangan berdasarkan 5 moment di bulan Maret 2025 sebesar

- Sebelum kontak dengan pasien sebesar 56,40%
- Sebelum tindakan aseptik sebesar 49,07%
- Setelah terpapar cairan tubuh pasien sebesar 58,37%
- Setelah kontak dengan pasien sebesar 64,88%

e. Setelah dari lingkungan pasien sebesar 54,53%

Gambar 4.1.3.3 Kepatuhan Kebersihan Tangan



Interpretasi : Pada gambar 4.1.3.3 diketahui bahwa rerata kepatuhan kebersihan tangan di bulan Maret 2025 sebesar 78,95%.

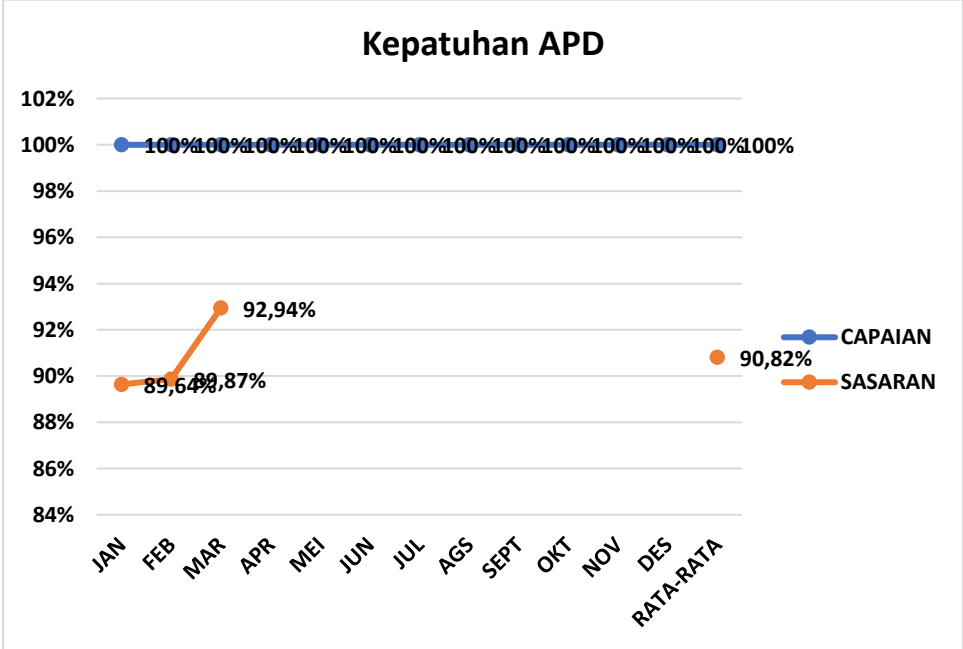
Tabel 4.1.3.3 Kepatuhan Kebersihan Tangan

PROBLEM	Persentase kepatuhan kebersihan tangan bulan Maret tahun 2025 sebesar 78,95% dan belum memenuhi target ≥85%.
STEP	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya kebersihan tangan untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan.
PLAN	1. Rencana: Mengetahui kepatuhan kebersihan tangan secara berkesinambungan 2. Harapan Seluruh staf dapat melakukan <i>hand hygiene</i> dengan Teknik 6 langkah dan 5 momen dengan tepat sehingga target kepatuhan dapat dicapai. 3. Tindakan a. Membuat TOR untuk review pelatihan PPI dasar b. Berkolaborasi dengan kepala bidang terkait monitoring kepatuhan c. Membuat rencana metode <i>role play</i> HH untuk staf lama d. Melakukan edukasi kelompok atau individu dengan sasaran pengunjung rumahsakit yang dibuktikan dengan video edukasi.
DO	Kepatuhan kebersihan tangan dengan Teknik 6 langkah dan 5 momen sesuai 5 momen
STUDY	1. Rerata kepatuhan kebersihan tangan di bulan Maret tahun 2025 sebsar 76%. 2. Rerata kepatuhan kebersihan tangan berdasarkan unit pelayanan, unit dengan rerata kepatuhan ≥ 85% adalah

	ICU sebesar 100%. 3. Rerata kepatuhan kebersihan tangan berdasarkan profesi tertinggi adalah profesi dokter yaitu sebesar 78,95% walaupun belum mencapai standart 4. Rerata kepatuhan kebersihan tangan berdasarkan 5 momen didapatkan a) Sebelum kontak dengan pasien sebesar 56,40% b) Sebelum Tindakan aseptik sebesar 49,07% c) Setelah terpapar cairan tubuh pasien sebesar 58,37% d) Setelah kontak dengan pasien sebesar 64,88% e) Setelah dari lingkungan pasien sebesar 54,53% 5. Masih ditemukan staff tidak patuh dalam melakukan 5 momen dan 6 langkah cuci tangan dengan baik dan benar
ACTION	1. Review dan evaluasi pelaksanaan pelatihan PPI dasar 2. Kolaborasi dengan kabid terkait monitoring kepatuhan kebersihan tangan 3. Re-edukasi SPO <i>hand hygiene</i> berdasarkan 6 langkah sesuai 5 momen. 4. Jika ditemukan petugas yang tidak dapat mempraktikkan kebersihan tangan dengan benar, beri tugas untuk melakukan edukasi kelompok dan dikumpulkan berupa video. 5. Lakukan audit per nama petugas, koordinasi dengan Karu, SDM untuk penilaian kinerja. 6. Berikan <i>feedback</i> hasil audit dan monitoring 7. Pemberian teguran saat melakukan supervisi kebersihan tangan.

e. Kepatuhan APD

Gambar 4.1.3.4 Kepatuhan APD



Interpretasi : Pada gambar 4.1.3.4 diketahui bahwa rerata kepatuhan penggunaan APD di bulan Maret 2025 sebesar 92,94%.

Tabel 4.1.3.4 Kepatuhan APD Berdasarkan Unit

INDIKATOR PENILAIAN	BULAN												RATA- RATA
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3A	88,00%	100,00%	93,10 %										94%
3B	100,00%	90,00%	96,77%										95%
2A	33,33%	100,00%	98,04%										67%
2B	100,00%	100%	98,77%										100%
2D	0,00%	0%	0%										0%
MAT	88,00%	100%	97,22%										94%
NEO	88,89%	100%	100%										94%
ICU	100,00%	100%	79,17%										100%
IKO	100,00%	100%	0%										100%
IGD	98,65%	100%	100%										99%
IRJA	100,00%	89%	98,98%										94%
CS	27,27%	100%	0%										64%
As. Center	0,00%	0%	0%										0%
Farmasi	100,00%	100%	0%										100%
Laboratorium	83,33%	56%	52,38%										69%
Radiologi	60,00%	0%	66,67%										30%
Gizi dan Dapur	83,33%	76%	81,16%										80%
RM / PDF	0,00%	0%	0%										0%
CSSD	100,00%	0%	0%										50%
LAUNDRY	100,00%	0%	0%										50,00%
B3	87,72%	93,75%	83,33%										90,74%
LAIN-LAIN	0,00%	0,00%	0%										0,00%

Interpretasi : Pada tabel 4.1.3.4 diketahui bahwa rerata kepatuhan penggunaan APD berdasarkan di Unit di bulan Februari 2025 tertinggi di unit IRNA 2B sebesar 100%.

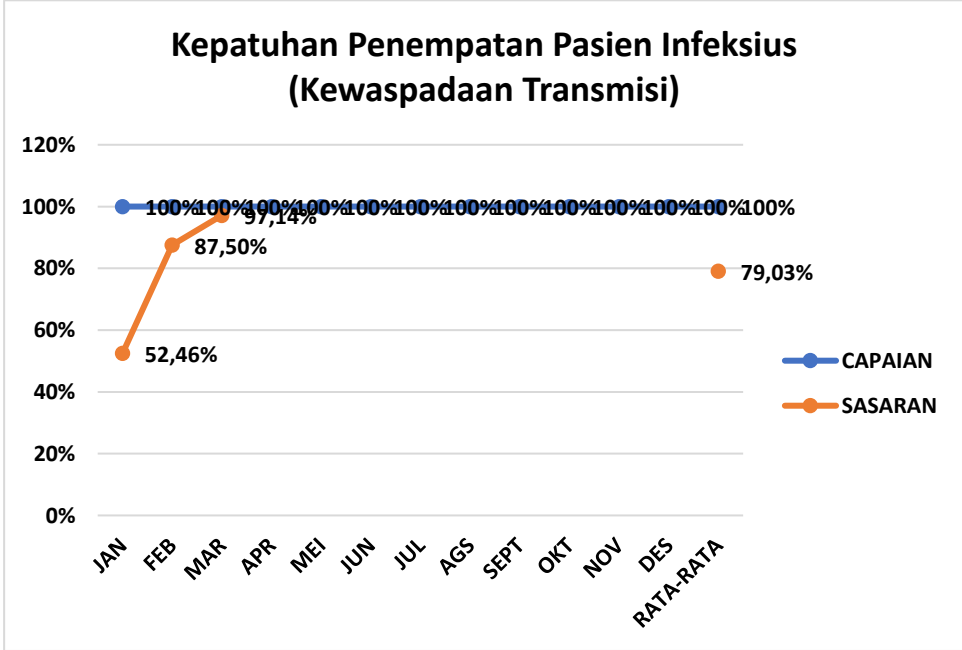
Tabel 4.1.3.5 Kepatuhan APD

PROBLEM	Persentase kepatuhan penggunaan APD tidak mencapai 100%.
STEP	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya penggunaan APD untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan.
PLAN	1. Rencana: Mengetahui kepatuhan penggunaan APD secara berkesinambungan 2. Harapan Seluruh staf pelayanan medik patuh dalam penggunaan APD dengan tepat sehingga target kepatuhan dapat dicapai. 3. Tindakan a. Melakukan audit penggunaan APD pada staf pelayanan medik di unit secara berkesinambungan. b. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi tentang penggunaan APD secara tepat c. Koordinasi dengan IPCLN di unit untuk meningkatkan kepatuhan penggunaan APD staf di unit. d. Koordinasi dengan Karu unit terkait kepatuhan staff dalam penggunaan APD untuk dimasukkan kedalam penilaian kinerja
DO	Kepatuhan penggunaan APD meningkat hingga mencapai 100% di bulan Maret tahun 2025.
STUDY	1. Rerata kepatuhan penggunaan APD pada bulan Maret tahun 2025 yaitu sebesar 92,94%, 2. Rerata kepatuhan penggunaan APD bulan Maret tahun 2025 yakni Neonatologi dan IGD sebesar 100%, 3. Ditemukan beberapa masalah seperti, a. Masih ditemukan CS yang menggunakan <i>handscoon</i> saat membuang limbah ke TPS. b. Masih ditemukan perawat yang menggunakan <i>handscoon</i> saat sebelum melakukan tindakan dan membawa troli dari <i>nurse station</i> c. Masih ditemukan CS tidak menggunakan sarung tangan saat melakukan pengambilan sampah di masing-masing unit d. Masih ditemukan petugas Lab tidak menggunakan gown di area sampling e. Masih ditemukan perawat tidak menggunakan APD saat melakukan Tindakan aseptik
ACTION	1. Review dan evaluasi hasil pelatihan penggunaan APD pada staf. 2. Beri feedback pada hasil temuan. 3. Kolaborasi dengan Karu masing-masing unit untuk monitoring penggunaan APD di unit. 4. Koordinasi dengan Karu CS untuk mendata dan

	melakukan penge-list an APD CS yang masih berfungsi dan yang rusak 5. Lakukan audit per nama petugas, koordinasi dengan Karu unit dan SDM untuk penilaian kinerja. 6. Beri teguran saat melakukan monitoring penggunaan APD yang tidak sesuai indikasi di lapangan
--	---

f. Kepatuhan Penempatan Pasien Infeksius

Gambar 4.1.3.5 Kepatuhan Penempatan Pasien Infeksius



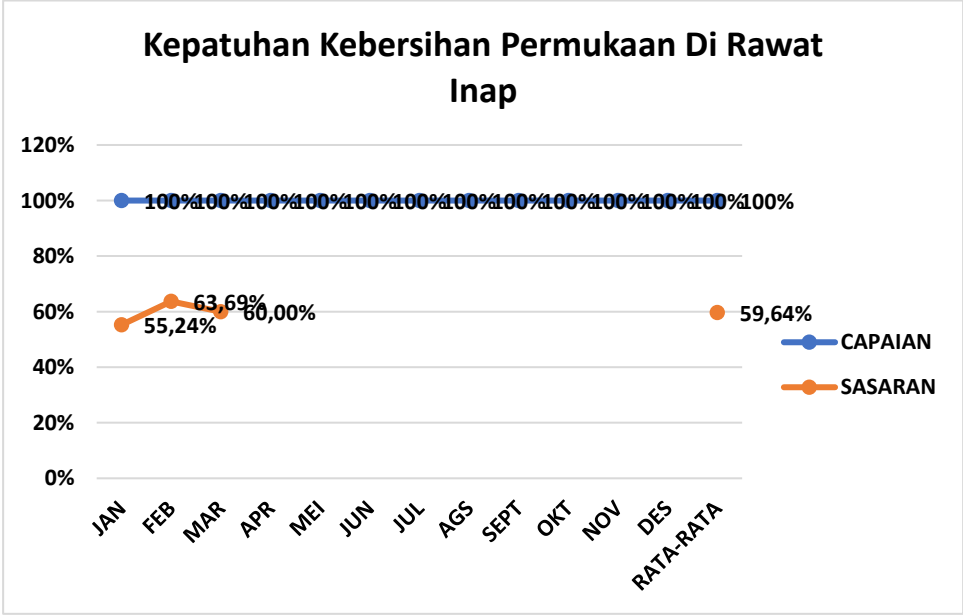
Interpretasi : Pada gambar 4.1.3.5 diketahui bahwa rerata kepatuhan penempatan pasien infeksius di bulan Maret 2025 sebesar 97,14%.

Tabel 4.1.3.6 Kepatuhan Penempatan Pasien Infeksius

PROBLEM	Persentase kepatuhan penempatan pasien infeksius belum mencapai 100%.
STEP	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya kepatuhan dalam penempatan pasien infeksius untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan serta mengurangi risiko tertularnya petugas dalam melakukan perawatan terhadap pasien dengan resiko penulara secara <i>airbone</i> .
PLAN	1. Rencana: Mengetahui kepatuhan penempatan pasien infeksius di unit secara berkesinambungan 2. Harapan Seluruh staf patuh dalam kepatuhan penempatan pasien infeksius di unit sehingga target kepatuhan dapat dicapai. 3. Tindakan d. Melakukan audit kepatuhan penempatan pasien infeksius di unit secara

	berkesinambungan. e. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi tentang kepatuhan penempatan pasien infeksius f. Koordinasi dengan IPCLN di unit untuk meningkatkan kepatuhan penempatan pasien infeksius baik antar staf, pasien, keluarga bahkan hingga ke pengunjung.
DO	Kepatuhan penempatan pasien infeksius belum mencapai 100%.
STUDY	1. Rerata kepatuhan penempatan pasien infeksius bulan Maret tahun 2025 yaitu sebesar 97,14%, 2. Masih ditemukan kurangnya edukasi yang diberikan oleh staff terhadap penempatan pasien infeksius kepada pasien dan keluarga sehingga sering keluar masuk pengunjung yang tidak menggunakan masker, 3. Masih ditemukan pengunjung keluar masuk ke dalam ruang isolasi dan tanpa menutup pintu 4. Ditemukan beberapa rekam medis tidak tertulis edukasi pasien dan keluarga terkait tata tertib ruang isolasi , 5. Ditemukan staff IRNA 2A tidak menggunakan APD yang sesuai seperti masker N95, 6. Masih ditemukan pasien non infeksius di letakkan di dalam ruang isolasi <i>immunocompromised</i>, 7. Masih ditemukan ruang kohorting di jadikan satu dengan pasien non infeksius.
ACTION	1. Review kepada staf terkait kepatuhan penempatan pasien infeksius. 2. Lakukan koordinasi dengan Karu IRNA 2A untuk melakukan re-sosialisasi kembali kepada staff terhadap kepatuhan penempatan pasien infeksius yang dibuktikan dengan terisinya form edukasi terkait tata tertib ruang isolasi 3. Lakukan edukasi kepada keluarga dan pengunjung isolasi untuk tidak keluar masuk ruang isolasi secara bebas, penggunaan APD serta etika batuk yang dibuktikan dengan edukasi kelompok (baik berupa foto atau video) 4. Aktivkan CCTV diarea R. Isolasi dan lakukan kolaborasi dengan satpam RS 5. Beri feedback pada hasil temuan. 6. Beri teguran pada unit yang tidak melakukan penempatan pasien infeksius.

g. Kepatuhan Kebersihan Permukaan di Rawat Inap
Gambar 4.1.3.6 Kepatuhan Kebersihan Permukaan di Rawat Inap



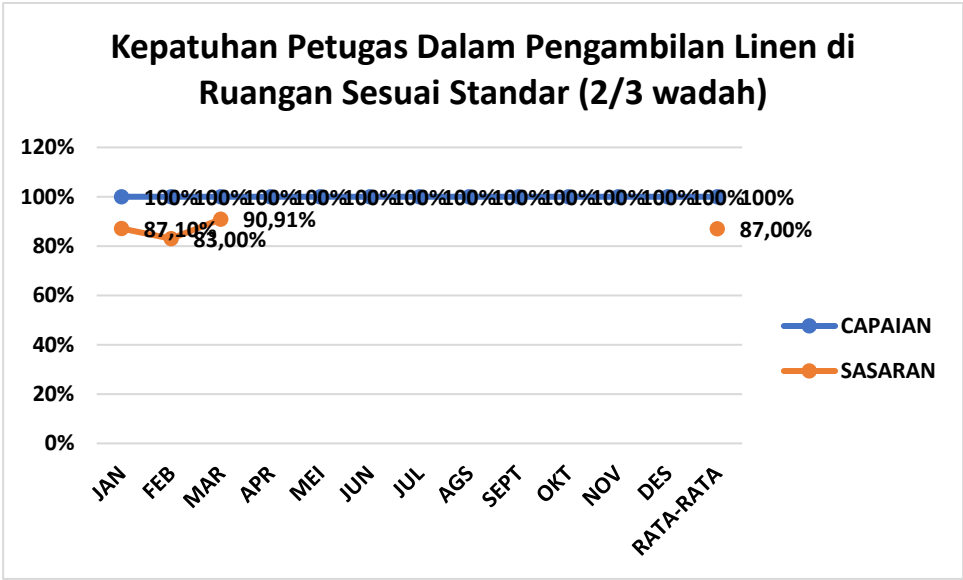
Interpretasi : Pada gambar 4.1.3.6 diketahui bahwa rerata kepatuhan kebersihan permukaan di rawat inap di bulan Maret 2025 sebesar 60%.

Tabel 4.1.3.7 Kepatuhan Kebersihan Permukaan di Rawat Inap

PROBLEM	Persentase kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan belum mencapai 100%.
STEP	Memonitor berkelanjutan dalam mempertahankan atau meningkatkan kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan
PLAN	1. Rencana: Mengetahui kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan di unit secara berkesinambungan 2. Harapan Seluruh staf patuh dalam pengendalian infeksi lingkungan di unit sehingga target kepatuhan dapat dicapai. 3. Tindakan a. Melakukan audit pengendalian infeksi lingkungan di unit secara berkesinambungan. b. Meningkatkan pelaksanaan edukasi dan sosialisasi tentang pengendalian infeksi lingkungan di unit. c. Koordinasi dengan IPCLN di unit untuk meningkatkan kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan di unit. 4. Sumber daya a. Petugas kebershan CS yang terlatih b. Peralatan pembersih yang memadai c. SOP dan panduan visual untuk kebersihan d. Peningkatan supervisi lebih sering
DO	Monitoring dan audit kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan mencapai target 100% dengan, a. Memastikan setiap kamar kosong dibersihkan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan b. Menggunakan cheklist untuk memastikan setiap sudut

	kamar di bersihkan termasuk tempat tidur, furnitur dan kamar mandi c. Melakukan sesi pelatihan ulang terkait pembersihan yang lebih detail, terutama pada area tempat tidur, kamar mandi, nakas dan dinding d. Menggunakan panduan visual yang menunjukkan dengan jelas area yang perlu di bersihkan lebih intensif e. Melakukan penjadwalan pembersihan tirai/gorden setiap bulan atau lebih sering jika di perlukan f. Mensosialisasikan pentingnya kebersihan dan penanganan kebersihan lingkungan kepada semua petugas baik kepada CS dan perawat
STUDY	1. Rerata kepatuhan kebersihan permukaan di rawat inap bulan Maret tahun 2025 yaitu sebesar 60%. 2. Staff belum cukup baik dalam pengendalian kebersihan lingkungan dengan beberapa temuan sebagai berikut, a. Masih ditemukan beberapa area perawatan yang berdebu, kotor, dan tidak rapi serta ruangan bau tidak enak b. CS kurang detail dalam pembersihan sehingga saat disupervisi ditemukan area bed dan nakas tampak kotor c. Masih ditemukan troli tindakan yang terdapat bercak noda darah d. Masih ditemukan tirai/gorden di ruang perawatan yang kotor, berdebu dan di lipat diatas bed e. Masih ditemukan linen infeksius yang tergeletak dilantai f. Masih ditemukan area kamar pasien atau kamar mandi pasien yang masih kotor dan berbau 3. Metrik evaluasi yang digunakan, a. Audit kebersihan kamar kosong b. Audit kebersihan oleh CS c. Audit kebersihan troli tindakan d. Evaluasi kebersihan tirai/gorden e. Penanganan linen infeksius f. Evaluasi kebersihan kamar pasien dan kamar mandi
ACTION	1. Kolaborasi dengan tim umum terkait pengadaan sumber daya pembersihan lingkungan. 2. Beri feedback pada hasil temuan. 3. Beri teguran saat melakukan monitoring pengendalian infeksi lingkungan di unit. 4. Monitoring pembersihan dan disinfeksi permukaan lingkungan yang berisiko tinggi

- h. Kepatuhan Petugas Dalam Pengambilan Linen di Ruangan Sesuai Standart 2/3 Wadah
- Gambar 4.1.3.7 Kepatuhan Petugas Dalam Pengambilan Linen di Ruangan Sesuai Standart 2/3 Wadah



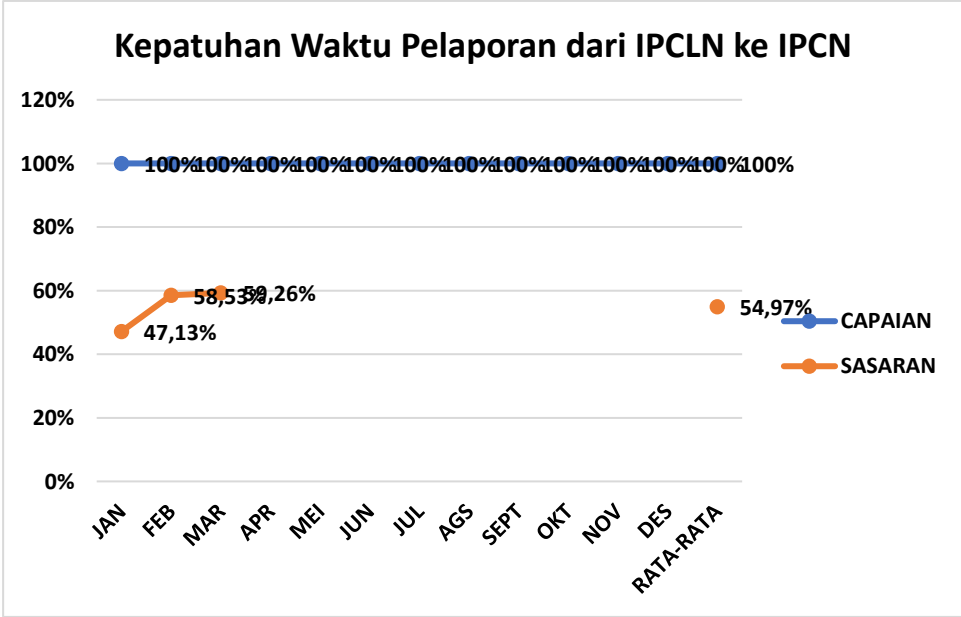
Interpretasi : Pada gambar 4.1.3.7 diketahui bahwa rerata kepatuhan petugas dakan pengambilan linen di ruangan sesuai standart 2/3 wadah bulan Maret 2025 sebesar 90,91%.

Tabel 4.1.3.8 Kepatuhan Petugas Dalam Pengambilan Linen di Ruangannya Sesuai Standart 2/3 Wadah

PROBLEM	Kepatuhan petugas dalam pengambilan linen di ruangan sesuai standart 2/3 wadah belum mencapai 100%
STEP	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya petugas dalam pengambilan linen di ruangan sesuai standart 2/3 wadah untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun linen
PLAN	1. Rencana: Mengetahui kepatuhan petugas dalam pengambilan linen di ruangan sesuai standart 2/3 wadah di unit secara berkesinambungan 2. Harapan Seluruh staf patuh dalam pengambilan linen di ruangan sesuai standart 2/3 wadah di unit laundry sehingga target kepatuhan dapat dicapai. 3. Tindakan Melakukan audit kepatuhan petugas dalam pengambilan linen di ruangan sesuai standart 2/3 wadah di unit secara berkesinambungan. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi tentang kepatuhan petugas dalam pengambilan linen di ruangan sesuai standart 2/3 wadah. Koordinasi dengan IPCLN di unit untuk meningkatkan kepatuhan petugas dalam pengambilan linen di ruangan sesuai standart 2/3 wadah. Berkoordinasi dengan laundry terkait temuan limbah maupun alat kesehatan pada linen kotor dan pemilahan linen di unit yang tidak sesuai 2/3 wadah
DO	Kepatuhan petugas dalam pengambilan linen di

	ruangan sesuai standart 2/3 wadah mencapai 100% di bulan berikutnya
STUDY	1. Kepatuhan penanganan linen di unit belum mencapai 100%. 2. Masih ditemukan area tempat linen kotor melebihi 2/3 wadah terutama pada area perawatan IRNA 3A
ACTION	1. Re-sosialisasi kepada staf terkait kepatuhan petugas dalam pengambilan linen di ruangan sesuai standart 2/3 wadah 2. Beri feedback pada hasil temuan. 3. Beri teguran saat melakukan monitoring penanganan linen di unit, terutama pemilahan linen infeksius dan non infeksius, serta linen yang tidak terurai saat masuk di tong linen kotor. 4. Lakukan dan kaji ulang kapasitas tempat linen kotor, apabila dibutuhkan penambahan maka unit wajib melakukan SP penambahan tempat linen kotor

i. Kepatuhan Waktu Pelaporan dari IPCLN ke IPCN
Gambar 4.1.3.8 Kepatuhan Waktu Pelaporan dari IPCLN ke IPCN



Interpretasi : Pada gambar 4.1.3.8 diketahui bahwa rerata kepatuhan waktu pelaporan dari IPCLN ke IPCN bulan Maret 2025 sebesar 59,26%.

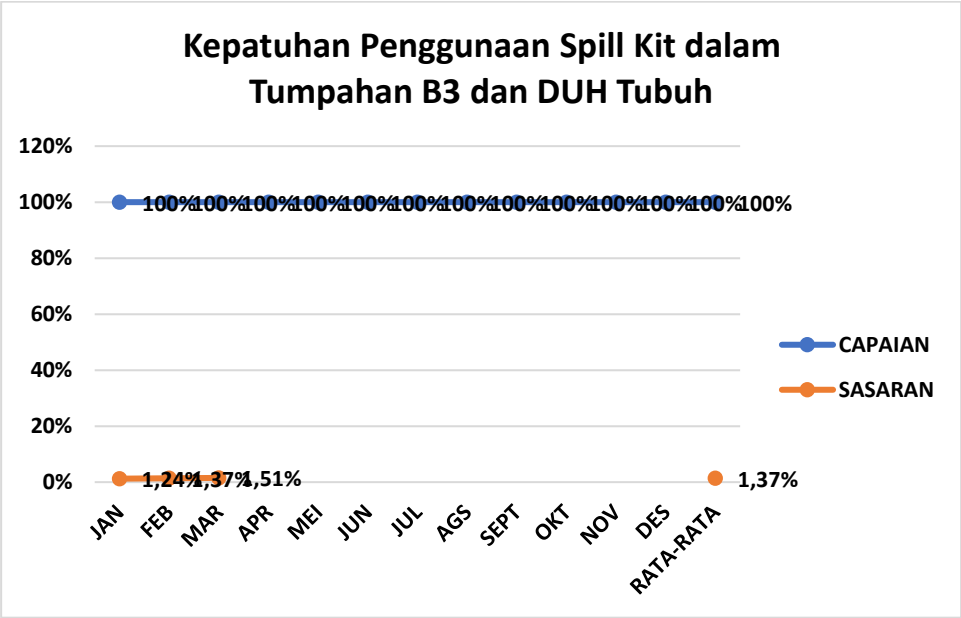
Tabel 4.1.3.9 Kepatuhan Waktu Pelaporan dari IPCLN ke IPCN

PROBLEM	Persentase kepatuhan waktu pelaporan dari IPCLN ke IPCN bulan Maret tahun 2025 sebesar 59,26% dan belum memenuhi target 100%
STEP	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya pelaporan dan penginputan hasil serta temuan di unit terkait surveilans HAI's dan monitoring kewaspadaan isolasi.
PLAN	1. Rencana: Mengetahui kepatuhan kelengkapan penginputan data surveilans secara berkesinambungan 2. Harapan Seluruh IPCLN dan PIC PPI unit melakukan pengnputan data surveilans secara real time dan ontime sehingga target kepatuhan dapat tercapai. 3. Tindakan a. Melakukan sosialisasi kepada seluruh IPCLN dan PIC PPI terhadap pelaporan melalui web PPI https://sites.google.com/view/komite-ppi-rsph-sukorejo b. Berkolaborasi dengan kepala ruang, kepala bidan dan SDM terkait kepatuhan IPCLN dan PIC PPI dalam melakukan kepatuhan penginputan data surveilans dan monitoring kewaspadaan isolasi.
DO	Kepatuhan kelengkapan penginputan data surveilans mencapai target 100%.
STUDY	1. Rerata kepatuhan kelengkapan penginputan data surveilans di tahun 2025 di bulan Maret 2025 sebesar 59,26% dan belum memenuhi standart. 2. Unit dengan kelengkapan penginputan data surveilans secara <i>on time</i> dan <i>real time</i> dari unit IRNA 2A 3. Ketidakpatuhan kelengkapan penginputan data surveilans disebabkan adanya, a. Perubahan data dan pembaruan web b. Staff IPCLN dan PIC PPI bertambah dan adanya perubahan formasi setelah adanya perotasian
ACTION	1. Lakukan pelatihan pengisian form PPI by web setiap bulan 2. Lakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap kelengkapan data yang telah di isi 3. Lakukan sosialisasi dan edukasi ulang kepada PIC PPI yang belum faha 4. Buatkan SPO pengisian data surveilans dan monitoring kewaspadaan isolasi 5. Lakukan audit per unit dengan identifikasi dan berikan award pada unit dengan tingkat kepatuhan tinggi dalam pelaporan 6. Berikan feedback hasil audit dan monitoring 7. Berikan teguran pada IPCLN dan PIC PPI yang tidak patuh dalam melakukan pelaporan

Link pelaporan dan ketepatan IPCLN dalam pelaporan ke IPCN :

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jXeIYCCJSp5JRMSbAEduydwwaSi-AOWHlxYA8QYuDgE/edit?usp=sharing>

- j. Kepatuhan Penggunaan Spillkit dalam Tumpahan B3 dan DUH Tubuh
- Gambar 4.1.3.9 Kepatuhan Penggunaan Spillkit dalam tumpahan B3 dan DUH Tubuh



Interpretasi : Pada gambar 4.1.3.9 diketahui bahwa rerata kepatuhan penggunaan spill kit dalam tumpahan B3 dan DUH tubuh bulan Maret 2025 sebesar 1,51%.

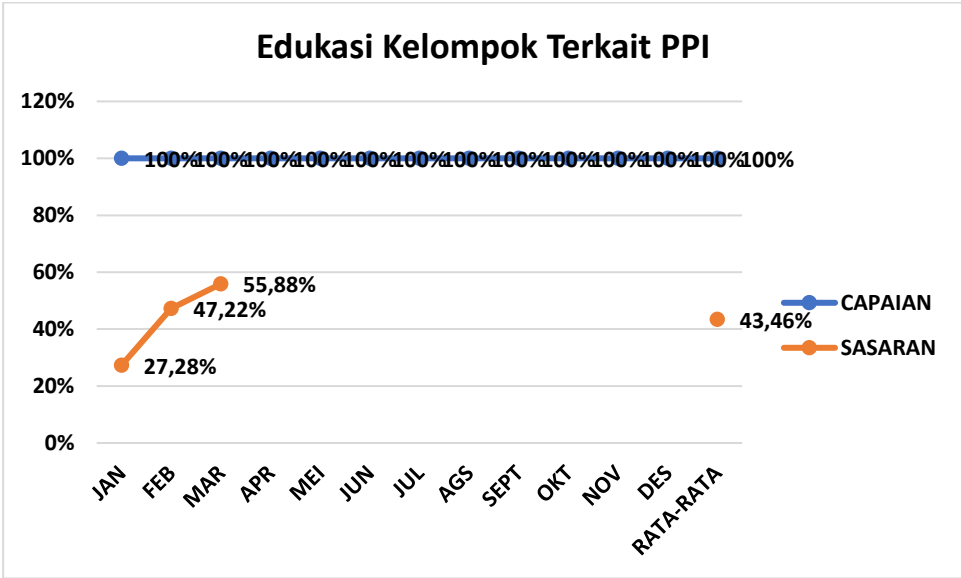
Tabel 4.1.3.10 Kepatuhan Penggunaan Spillkit dalam tumpahan B3 dan DUH Tubuh

PLAN	Meningkatkan kepatuhan penggunaan spillkit dalam tumpahan B3 dan DUH tubuh hingga mencapai target yaitu 100%.
DO	1. Monitoring kepatuhan kepatuhan penggunaan spillkit dalam tumpahan B3 dan DUH tubuh dilakukan menggunakan form supevisi 2. Checklist supervise spilkit belum 100% berjalan.
STUDY	1. Rerata kepatuhan penggunaan spillkit dalam tumpahan B3 dan DUH tubuh bulan Maret tahun 2025 sebesar 1,51% sehingga belum mencapai standart 100%. 2. Pelaporan tumpahan belum lengkap dilakukan oleh tim CS apabila ada tumpahan. 3. Ditemukan tumpahan dan percikan darah di troli injeksi IRNA 2A 4. Ditemukan tumpahan darah di area IGD
ACTION	1. Beri feedback hasil temuan. 2. Koordinasi dengan tim umum untuk selalu mengisi ulang bahan box spilkit setelah digunakan 3. Monitoring unit terkait kelengkapan box spilkit.

	4. Supervisi terkait pelaporan tumpahan. 5. Analisis kebutuhan spill kit di unit
--	---

Link pelaporan tumpahan dan penggunaan spill kit :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CV_mGIKtV5vjVPk4D1HuxC4sBZVbR0Li6EkPMAYpTMA/edit?usp=sharing

- k. Edukasi Kelompok Terkait PPI
- Gambar 4.1.3.10 Edukasi Kelompok terkait PPI



Interpretasi : Pada gambar 4.1.3.10 diketahui bahwa rerata kepatuhan edukasi kelompok terkait PPI bulan Maret 2025 sebesar 55,88%.

Tabel 4.1.4.11 Edukasi Kelompok terkait PPI

No	Nama Unit	Jmlh Edukasi	Jmlh Peserta	Topik	Sasaran
Januari					
1	IRNA 2A	1	5	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
2	IRNA 2B	1	5	Batuk Efektif	Pasien/Pengunjung
3	IRNA 3A	1	5	Phlebitis	Pasien/pengunjung
		1	5	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
		1	5	Hand hygiene	Pasien/Pengunjung
		1	5	Etika batuk	Pasien/pengunjung
		1	5	Etika batuk	Pasien/pengunjung
		1	5	Etika batuk	Pasien/pengunjung
4	IRNA 3B	1	5	Hand hygiene	Pasien/Pengunjung
5	Maternitas	1	5	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
		1	5	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
		1	5	Pencegahan Infeksi	Pasien/pengunjung
6	ICU	1	5	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
		1	5	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
		1	5	Etika Batuk	Pasien/pengunjung
7	IGD	1	5	Hand hygiene	Pasien/pengunjung

		1	5	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
8	RM/PDF	1	8	Hand hygiene	Staff
9	IKO	1	3	Pencegahan Infeksi pada pasien post op	Pencegahan Infeksi
Februari					
1	IRNA 2A	1	5	Batuk Efektif	Pasien/pengunjung
2	IRNA 2B	1	5	Batuk Efektif	Pasien/Pengunjung
		1	5	Phlebitis	Pasien/pengunjung
3	IRNA 3A	1	5	Batuk Efektif	Pasien/pengunjung
		1	5	Pemilahan Sampah	Pasien/pengunjung
		1	5	Batuk Efektif	Pasien/pengunjung
		1	5	Phlebitis	Pasien/pengunjung
4	IRNA 3B	1	5	Cuci tangan	Pasien/pengunjung
		1	5	Cuci tangan	Pasien/pengunjung
		1	5	Batuk efektif	Pasien/pengunjung
		1	5	Cuci tangan	Pasien/Pengunjung
		1	5	Batuk efektif	Pasien/pengunjung
		1	5	Batuk efektif	Pasien/pengunjung
5	ICU	1	5	Cuci tangan	Pasien/pengunjung
		1	5	Batuk efektif	Pasien/pengunjung
6	IGD	1	5	Cuci tangan	Pasien/pengunjung
		1	6	Batuk efektif	Pasien/pengunjung
		1	5	Cuci tangan	Pasien/pengunjung
		1	5	Phlebitis	Pasien/pengunjung
7	IRJA	1	5	Cuci tangan	Pasien/Pengunjung
8	Maternitas	1	5	Cuci tangan	Pasien/pengunjung
		1	5	Cuci tangan	Pasien/pengunjung
		1	5	Pencegahan infeksi	Pasien/pengunjung
9	Neonatologi	1	5	Cuci tangan	Pasien/pengunjung
		1	5	Cuci tangan	Pasien/pengunjung
10	RM/PDF	1	8	Cuci tangan	Staff
Maret					
1	IRNA 2A	1	5	Cuci tangan	Pasien/pengunjung
		2	5	Etika Batuk	Pasien/Pengunjung
		2	5	Plebitis	Pasien/pengunjung
2	IRNA 2B	1	5	Cuci tangan	Pasien/pengunjung
		1	5	Etika Batuk	Pasien/pengunjung
3	IRNA 3A	3	5	Cuci tangan	Pasien/Pengunjung
		1	5	Plebitis	Pasien/pengunjung
		1	5	Etika Batuk	Pasien/pengunjung
4	IRNA 3B	3	5	Cuci tangan	Pasien/pengunjung
		1	5	Etika batuk	Pasien/Pengunjung
5	Maternitas	1	5	Pencegahan IDO	Pasien/pengunjung
		1	5	Cuci tangan	Pasien/pengunjung
6	Neonatologi	2	5	Cuci tangan	Pasien/pengunjung
7	IGD	1	8	Cuci tangan	Pasien/Pengunjung
		1	8	Etika Batuk	Pasien/pengunjung
8	ICU	2	8	Cuci tangan	Pasien/pengunjung

9	Radiologi	1	6	Pemilahan sampah	Pasien/pengunjung
10	IRJA	1	2	Cuci tangan	Pasien/pengunjung

Tabel 4.1.4.12 Edukasi Kelompok terkait PPI

PLAN	Meningkatkan kepatuhan edukasi kelompok terkait PPI hingga mencapai target yaitu 100%.
DO	1. Monitoring kepatuhan edukasi kelompok terkait PPI dilakukan menggunakan form supevisi 2. Belum semua unit melakukan edukasi sesuai dengan standart.
STUDY	1. Rerata kepatuhan edukasi terkait PPI bulan Maret tahun 2025 sebesar 55,88% sehingga belum mencapai standart 100%. 2. Edukas terkait PPI belum berjalan di beberapa pelayanan penunjang 3. Edukasi terkait PPI berjalan diunit pelayanan namun belum 100%.
ACTION	1. Beri feedback akan adanya kendala dalam melakukan edukasi kelompok atau individu 2. Koordinasi dengan IPCLN untuk melakukan penjadwalan edukasi kelompok atau individu 3. Monitoring dan evaluasi unit terkait kepatuhan edukasi melalui link edukasi .

4.2

Kesehatan karyawan

Tabel 4.2. Data Kesehatan Karyawan

No	Bulan	Jumlah Staf yang MCU	Jenis Pemeriksaan				Keterangan	Hasil Pemeriksaan
			Fisik	Thorax	HbsAg	HIV		
1.	Januari	-	-	-	-	-	-	-
2.	Februari	-	-	-	-	-	-	-
3.	Maret							
4.								

Interpretasi : Pada tabel 4.2 terkait data kesehatan karyawan tidak ada kegiatan MCU staff pada bulan Maret 2025.

Tabel 4.2.1 Data Kesehatan Karyawan

PLAN	Meningkatkan kepatuhan staff dalam melakukan kegiatan MCU yang bertujuan untuk skrining utama terhadap rantai infeksi yang terjadi pada tenaga kesehatan
DO	Monitoring kepatuhan staff dalam melakukan MCU karyawan yang dilakukan secara terjadwal
STUDY	Rerata kepatuhan Kesehatan karyawan bulan Maret 0 dikarenakan tidak ada agenda MCU staff dari SDM.
ACTION	1. Koordinasi dengan SDM untuk penjadwalan MCU staff 2. Beri feedback akan adanya temuan hasil dari MCU staff 3. Monitoring dan evaluasi kegiatan MCU staff secara berkesinambungan.

BAB V.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kinerja komite PPI pada tahun 2025 didapatkan masih ditemukan banyaknya penilaian yang tidak mencapai target dan masih ditemukan beberapa masalah seperti,

- a. Kepatuhan petugas dalam melakukan *hand hygien*,
- b. Kepatuhan petugas dalam penggunaan APD,
- c. Kepatuhan penyuntikan,
- d. Kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan,
- e. Kepatuhan penanganan limbah,
- f. Kepatuhan penanganan pembuangan jarum dan benda tajam,
- g. Kepatuhan penanganan tumpahan darah,
- h. Kepatuhan pelayanan makanan,
- i. Kejadian phlebitis dalam 2025,
- j. Ketidakpatuhan petugas dalam melakukan pelaporan dan pengisian di web komite PPI 2025

5.2 Saran

Dari hasil penulisan dan pelaporan tahunan Komite PPI 2025 diharapkan adanya perbaikan yang dapat dilakukan oleh semua unit dalam proses pelaporan dan penugasan dari Komite PPI terkait,

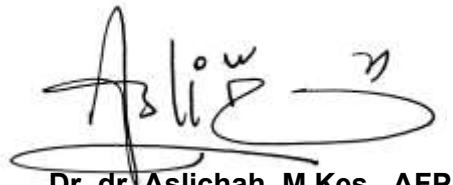
- a. Pengambilan data di unit oleh IPCLN/PIC PPI Unit terkait audit bundle HAI's, pelaporan HAI's, monitoring dan supervisi, sosialis PPI kepada pasien/keluarga/pengunjung pasien,
- b. Evaluasi dalam berjalannya ICRA Program di unit yang berhubungan dengan Bundle HAI's.

BAB VI.
PENUTUP

Demikian laporan bulan Maret tahun 2025 Komite PPI disusun dan disampaikan sebagai acuan dalam pelaksanaan evaluasi pelayanan kesehatan di RS Prima Husada Sukorejo tahun 2025. Segala dukungan dan kerjasama yang diberikan dapat menunjang perbaikan pelayanan di tahun berikutnya.

Pasuruan, 5 April 2025

Mengetahui,
Ketua Komite PPIRS



Dr. dr. Aslichah, M.Kes., AFP

IPCN



Dwi Siska Hardiyanti, S.Kep., Ns.

Menyetujui,
Direktur RS Prima Husada Sukorejo



dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS.

Lampiran :

1. Link Supervisi PPI 2025 :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JO8PKQG1PkET_U3IODHmUxZfTRMy1JLkgvpP_PzQRRRA/edit?usp=sharing
2. Link Rekap PPI 2025 :
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Pf750mUyrg4oJueUUI58h-qF3exSXqQd/edit?usp=sharing&ouid=112068003789464975539&rtpof=true&sd=true>